

皮膚科で行う検査は？

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 講師

真柄徹也



皮膚科で行う検査は？

まずどのようなものか思いつくでしょうか？



医師国家試験

120D24

50歳の女性。顔面の皮疹を主訴に来院した。3日前から38℃台の発熱、悪寒を認め、顔面に熱感を伴う皮疹が出現し、急速に両側に拡大した。右耳後部リンパ節の腫大を認めた。

血液所見：赤血球458万、Hb 12.5 g/dL、白血球12,100、血小板34万。CRP 7.8 mg/dL。右顔面皮疹の写真を別に示す。最も考えられる診断はどれか。

1. せつ
2. 丹毒
3. ひょう疽
4. ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)
5. 蜂窩織炎

No. 6

(D 問題 24)



医師国家試験

120D24

50歳の女性。顔面の皮疹を主訴に来院した。3日前から38℃台の発熱、悪寒を認め、顔面に熱感を伴う皮疹が出現し、急速に両側に拡大した。右耳後部リンパ節の腫大を認めた。

血液所見：赤血球458万、Hb 12.5 g/dL、白血球12,100、血小板34万。CRP 7.8 mg/dL。右顔面皮疹の写真を別に示す。最も考えられる診断はどれか。

1. せつ
2. 丹毒
3. ひょう疽
4. ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)
5. 蜂窩織炎

No. 6

(D 問題 24)



丹毒と蜂窩織炎の違いは？

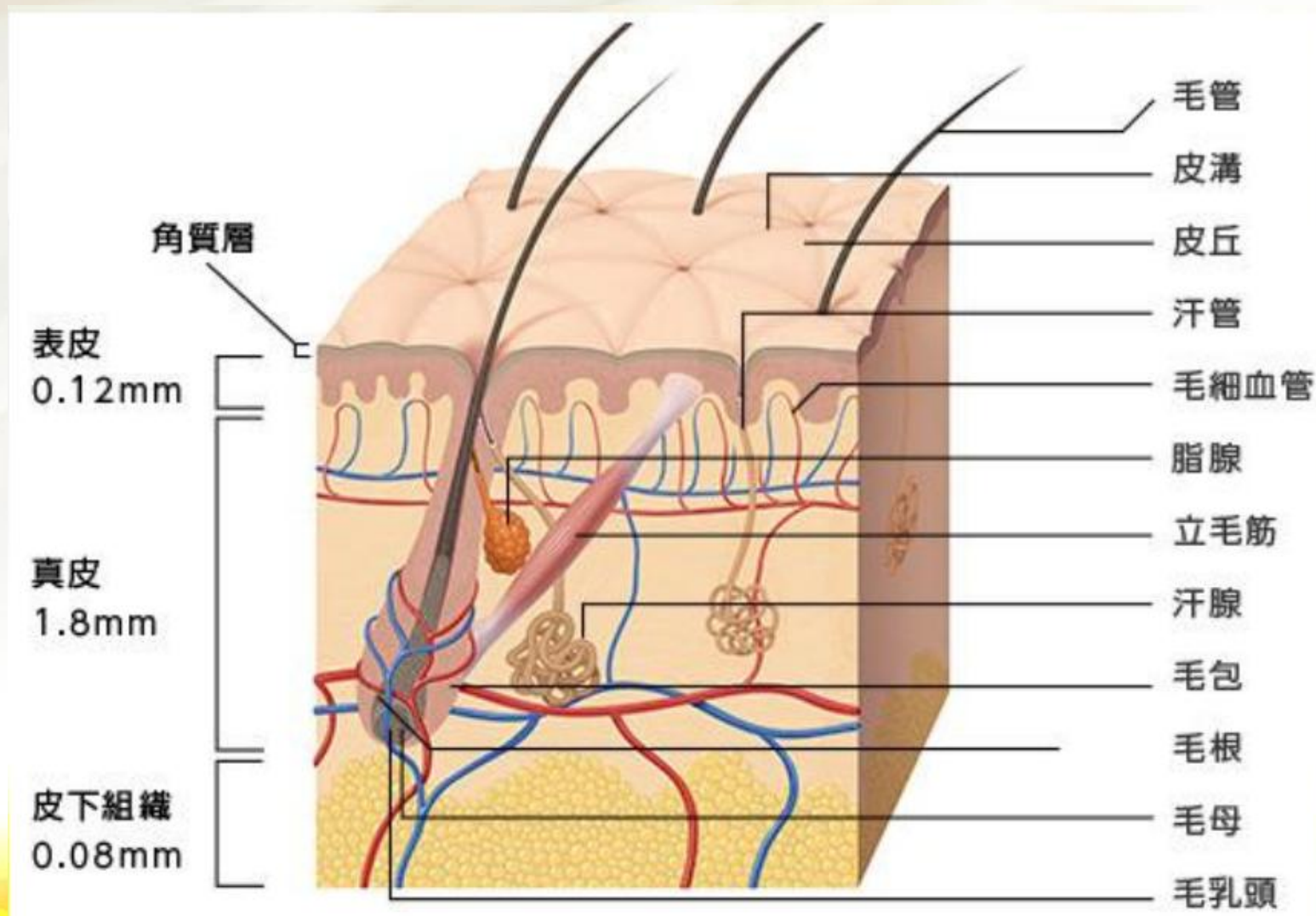
視診（触診）

丹毒と蜂窩織炎の違いは？

- ①部位
- ②病原菌の種類の違い
- ③病変の深さ



視診(触診)



丹毒：
真皮の病変

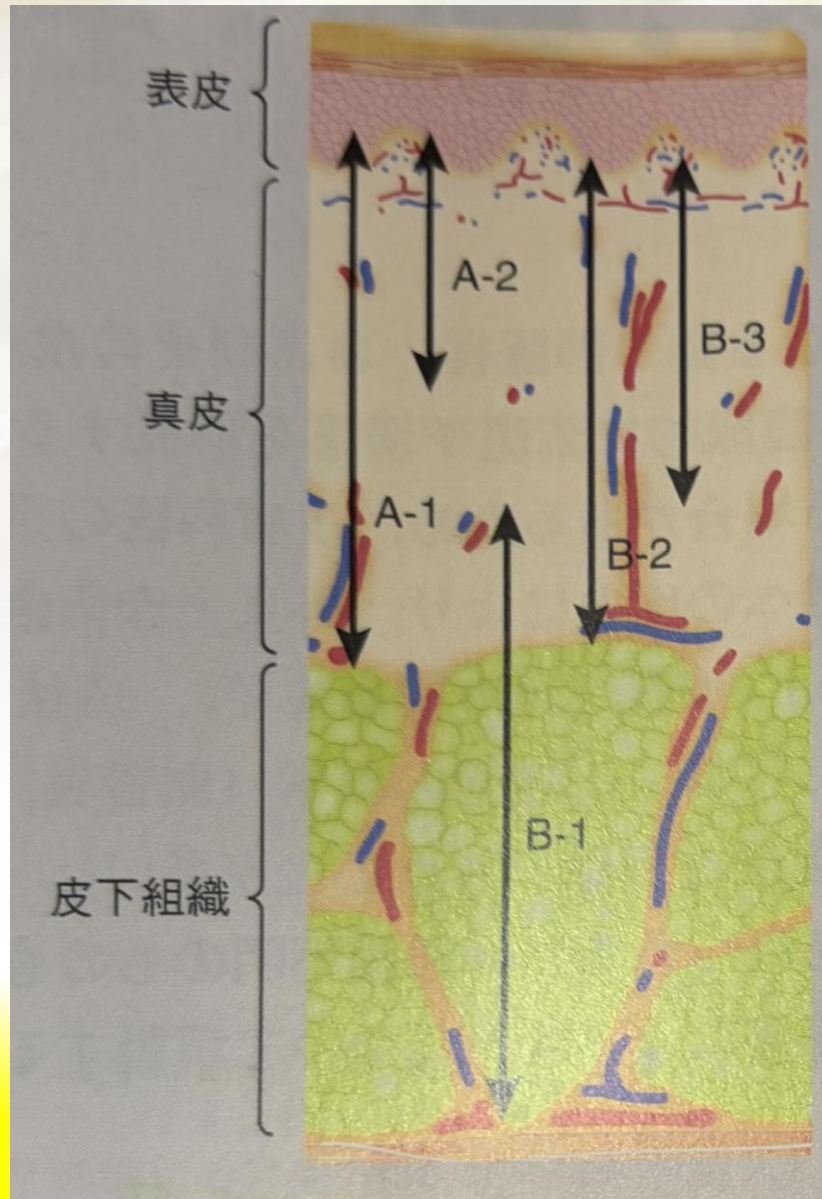
蜂窩織炎：
皮下組織の病変

視診（触診）



ともに血管炎です！

視診(触診)



A-1: 皮膚白血球破碎性血管炎

A-2: IgA血管炎

B-1: 結節性多発動脈炎

B-2: 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

B-3: 多発血管炎性肉芽腫症

視診(触診)



IgA血管炎

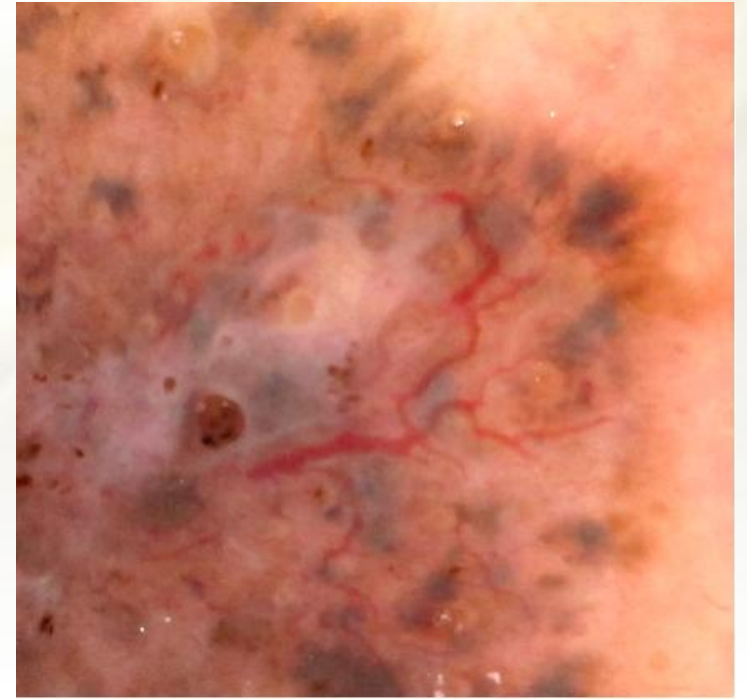
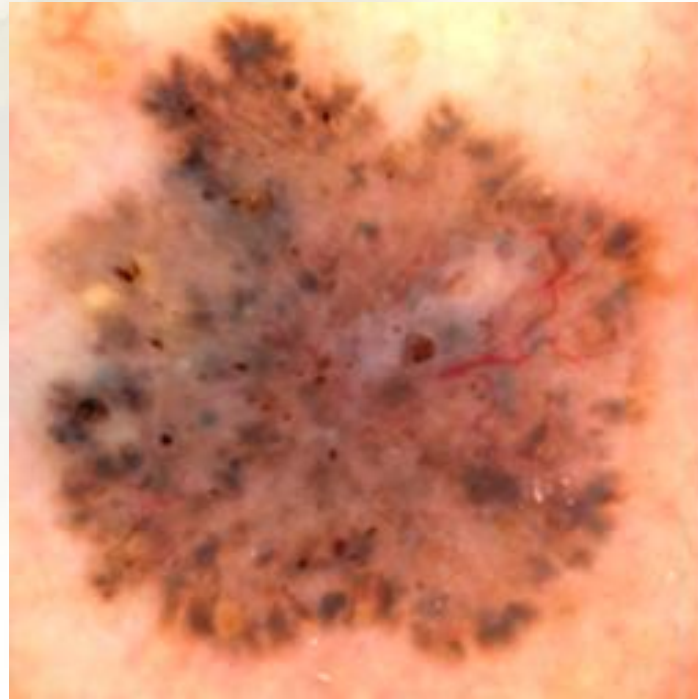
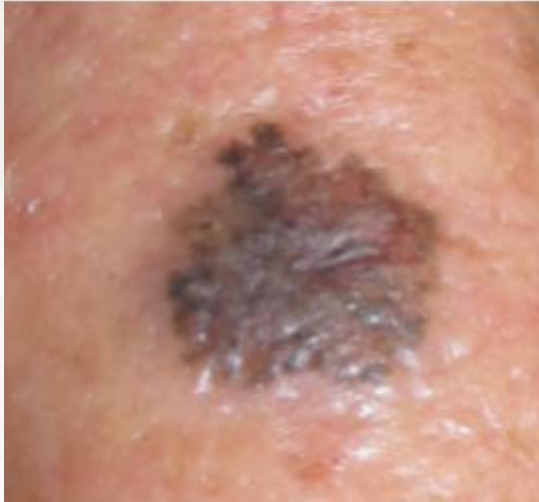


結節性多発動脈炎

ダーモスコピー



ダーモスコピー



Leaf like area
樹枝状血管
→基底細胞癌の所見

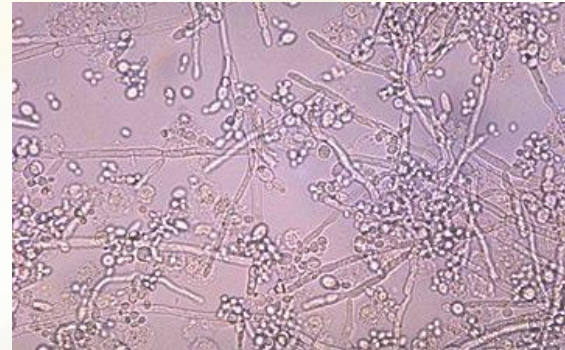
皮膚表在性感染症を疑った際にする検査は？

- 直接検鏡 (KOH)
- 培養
- ウイルス抗原検査
- 血清診断
- 病理組織学的検査



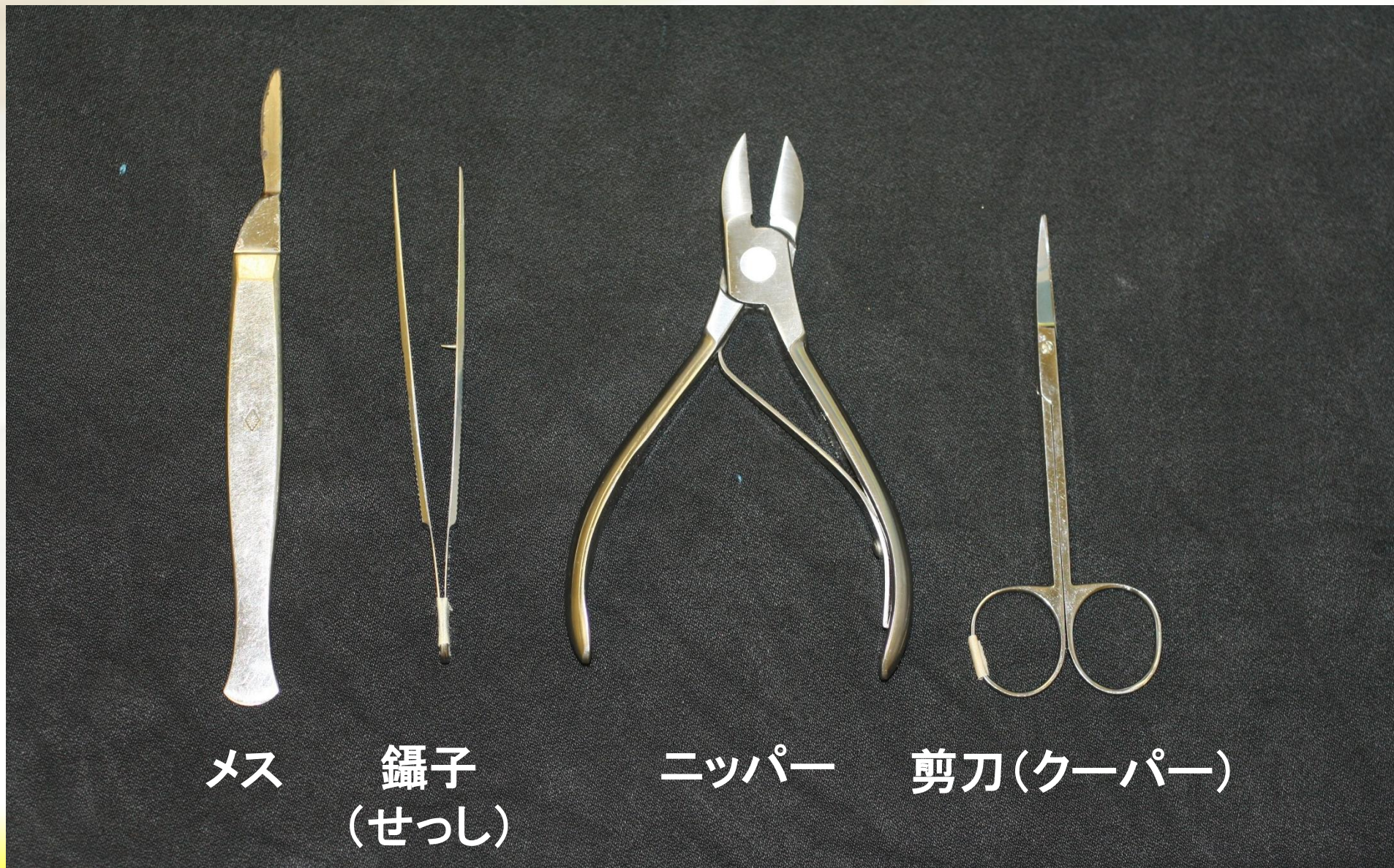
直接検鏡(KOH)

病巣の角質を削り取り、顕微鏡で菌の有無を検索する



<検査材料>

- 角質
- 爪
- 毛
- 水疱蓋など



メス

鑷子
(せっし)

ニッパー

剪刀(クーパー)

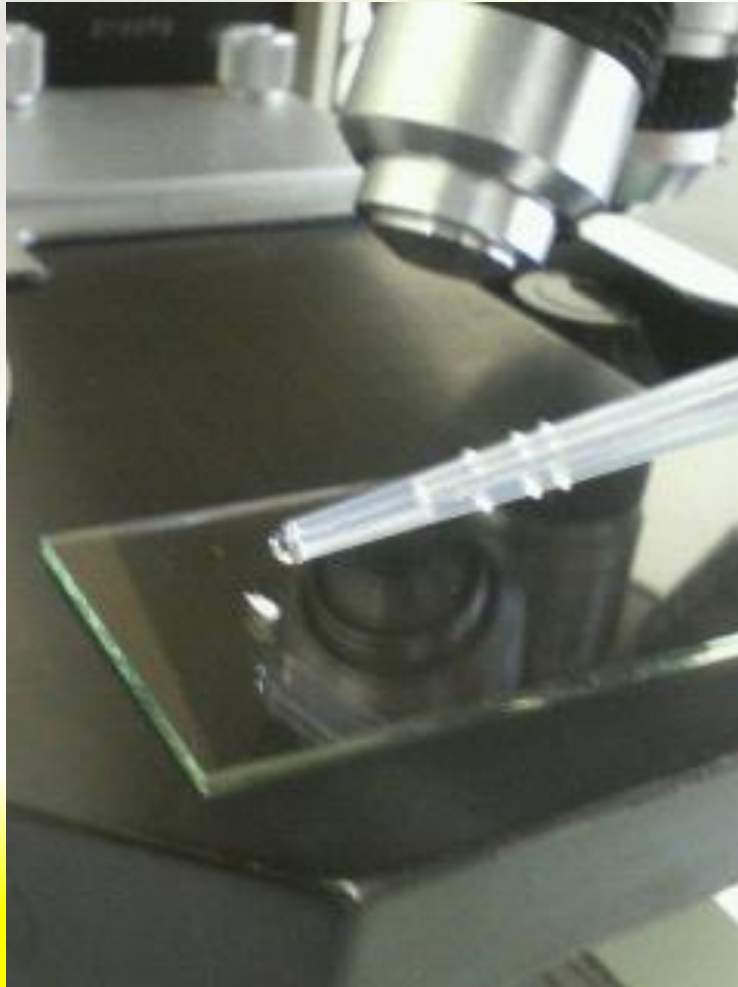
検体採取の道具



KOHで角質を溶解する

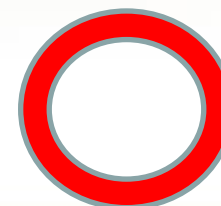
直接検鏡(KOH)

KOHで角質を溶かす



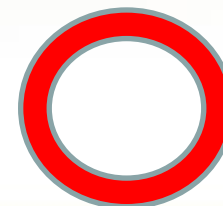
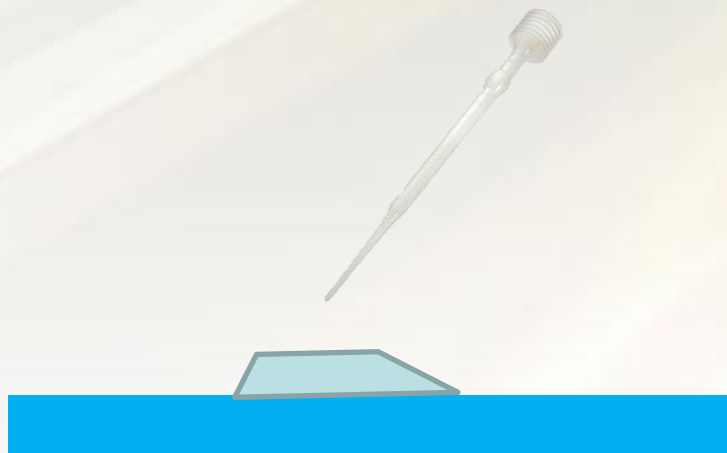
直接検鏡(KOH)

検体を置く位置（アルコールランプ使用时）



直接検鏡(KOH)

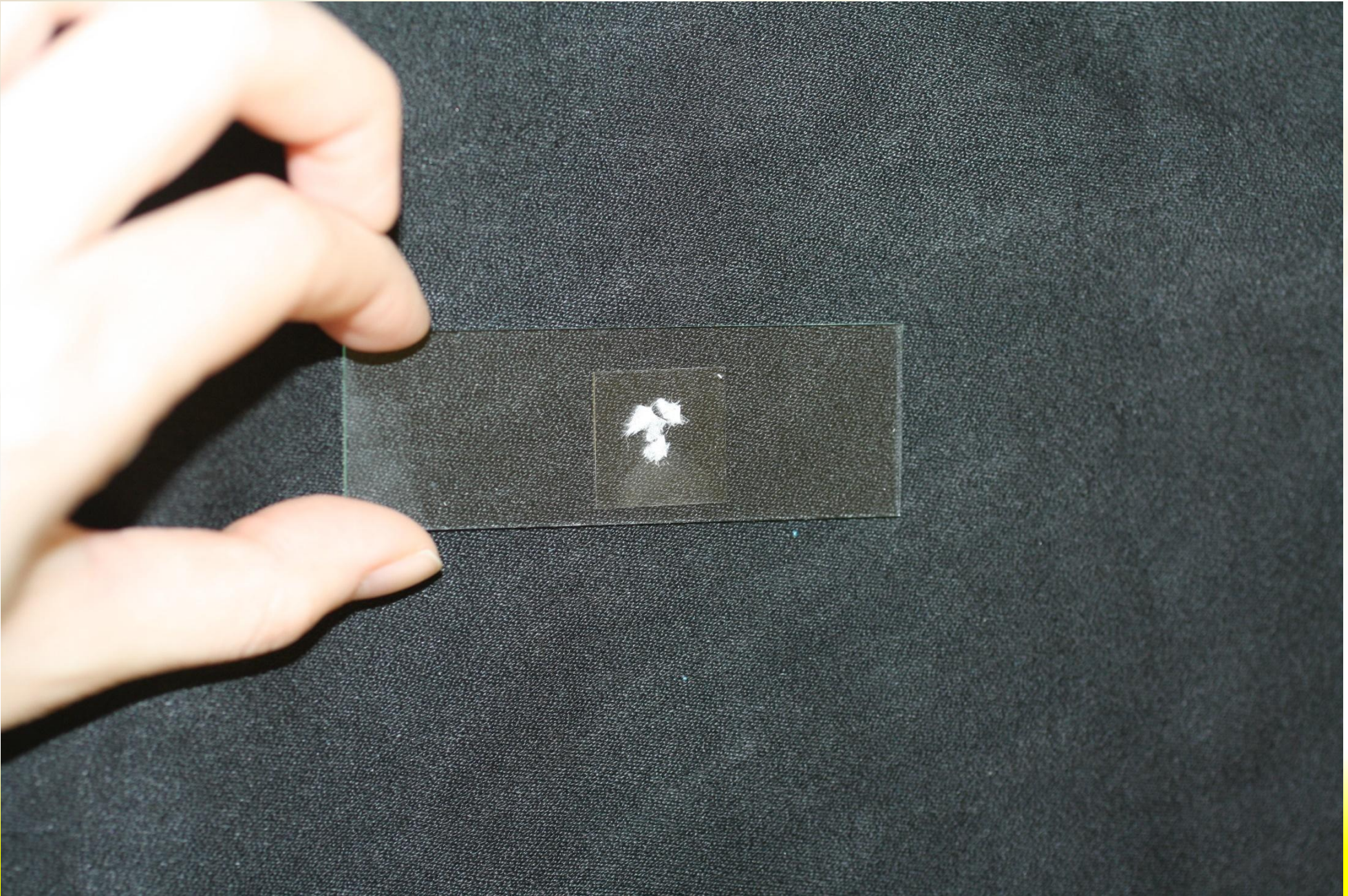
KOHをうまく垂らす際のコツ

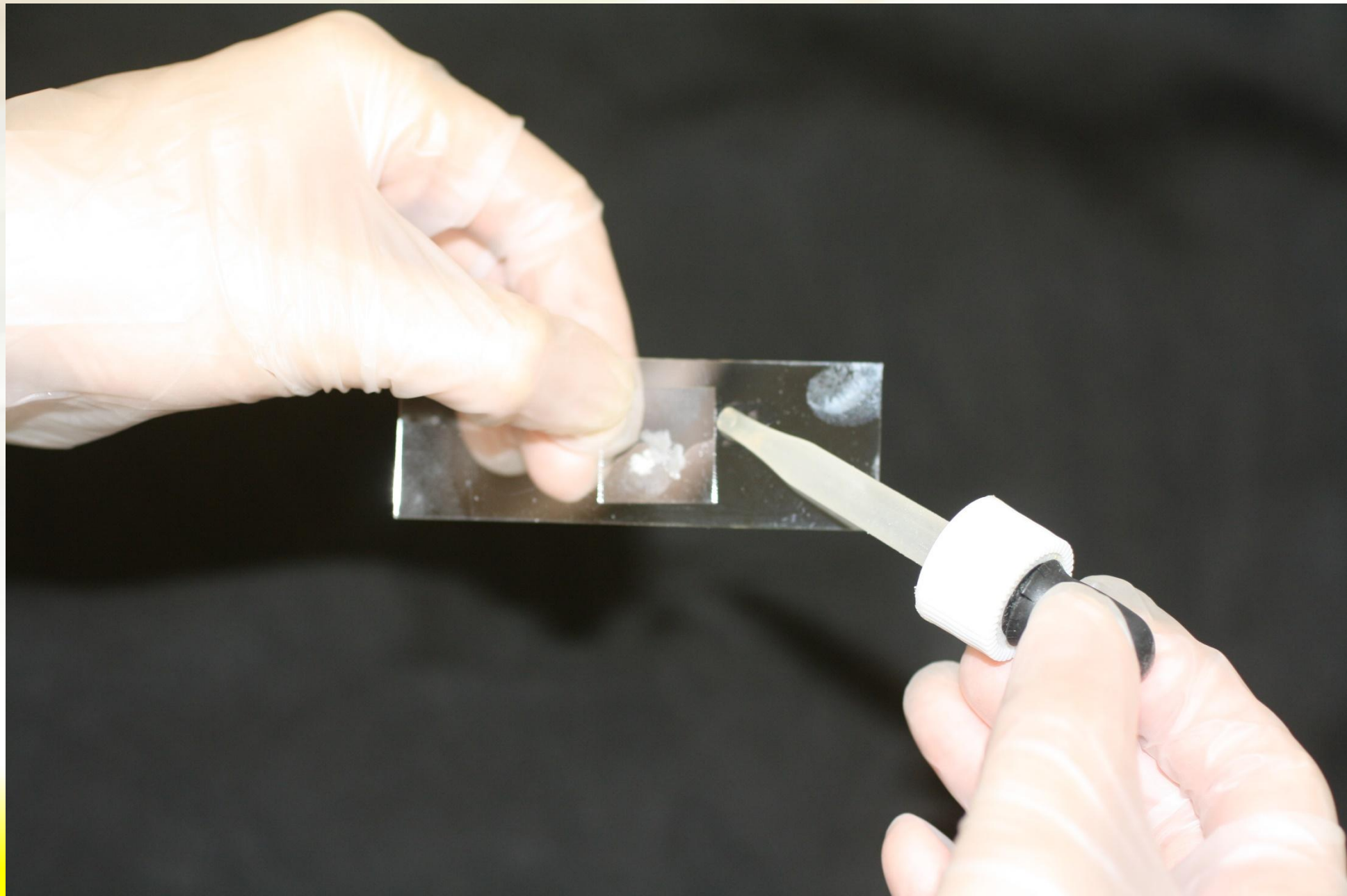




保温機を使用する方法







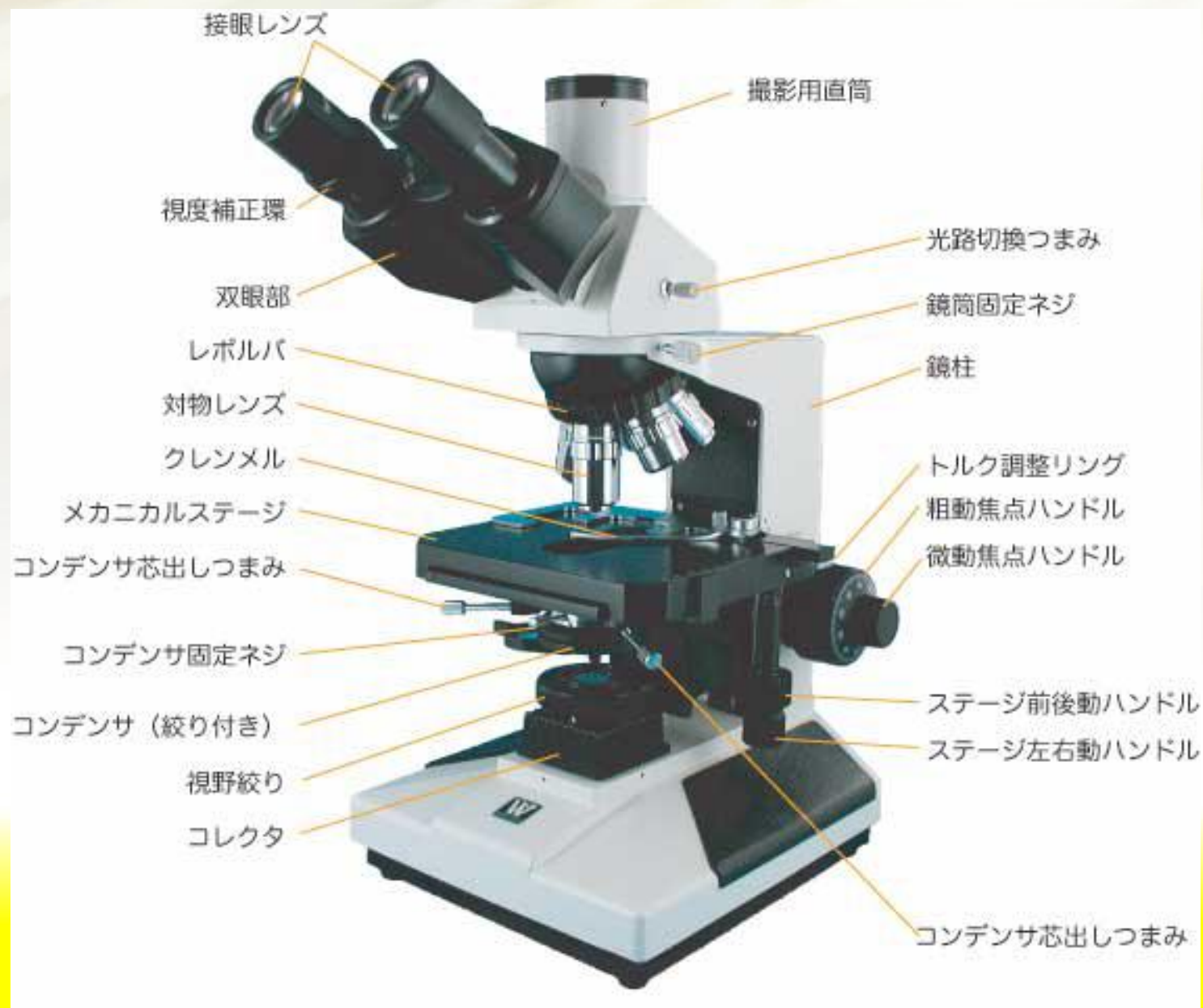


直接検鏡(KOH)

- 1) 検体はできるだけ細かく採取
- 2) プレパラートの端から1/3程度の部分に乗せる
- 3) カバーガラスを乗せた後にKOH液を横から垂らす
- 4) KOHは少なめに使用するのがコツ
- 5) KOHを垂らした後、少しつぶす
- 6) スライドグラスをやや傾け、アルコールランプにかける
- 7) 検体が徐々に透明になってくるまで行う



直接検鏡(KOH)





右側

コンデンサー

電源、光源の明るさ調節

ピントの微調整

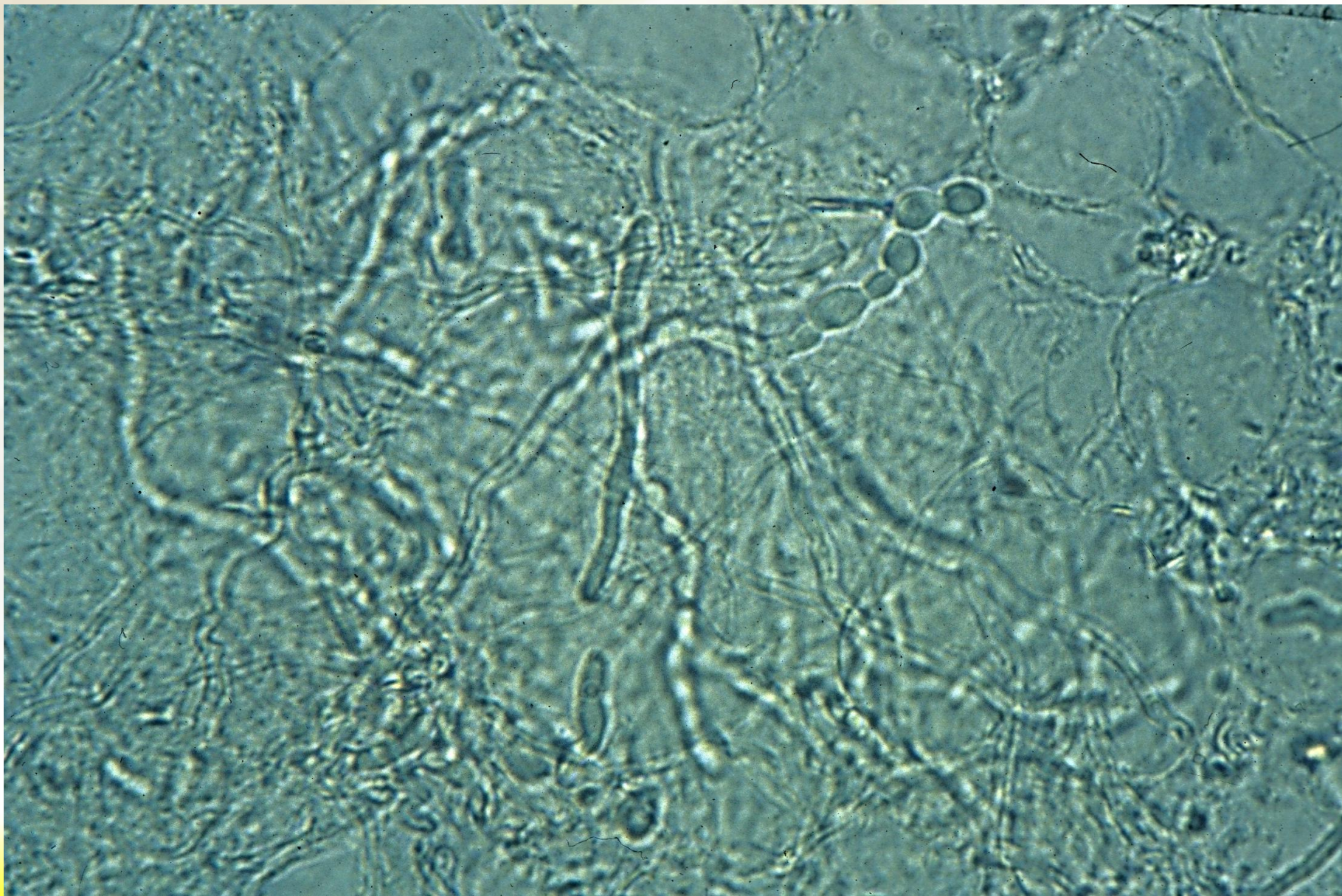
コンデンサーとは・・・
照明光を有効に試料面に集光させるための装置

左側

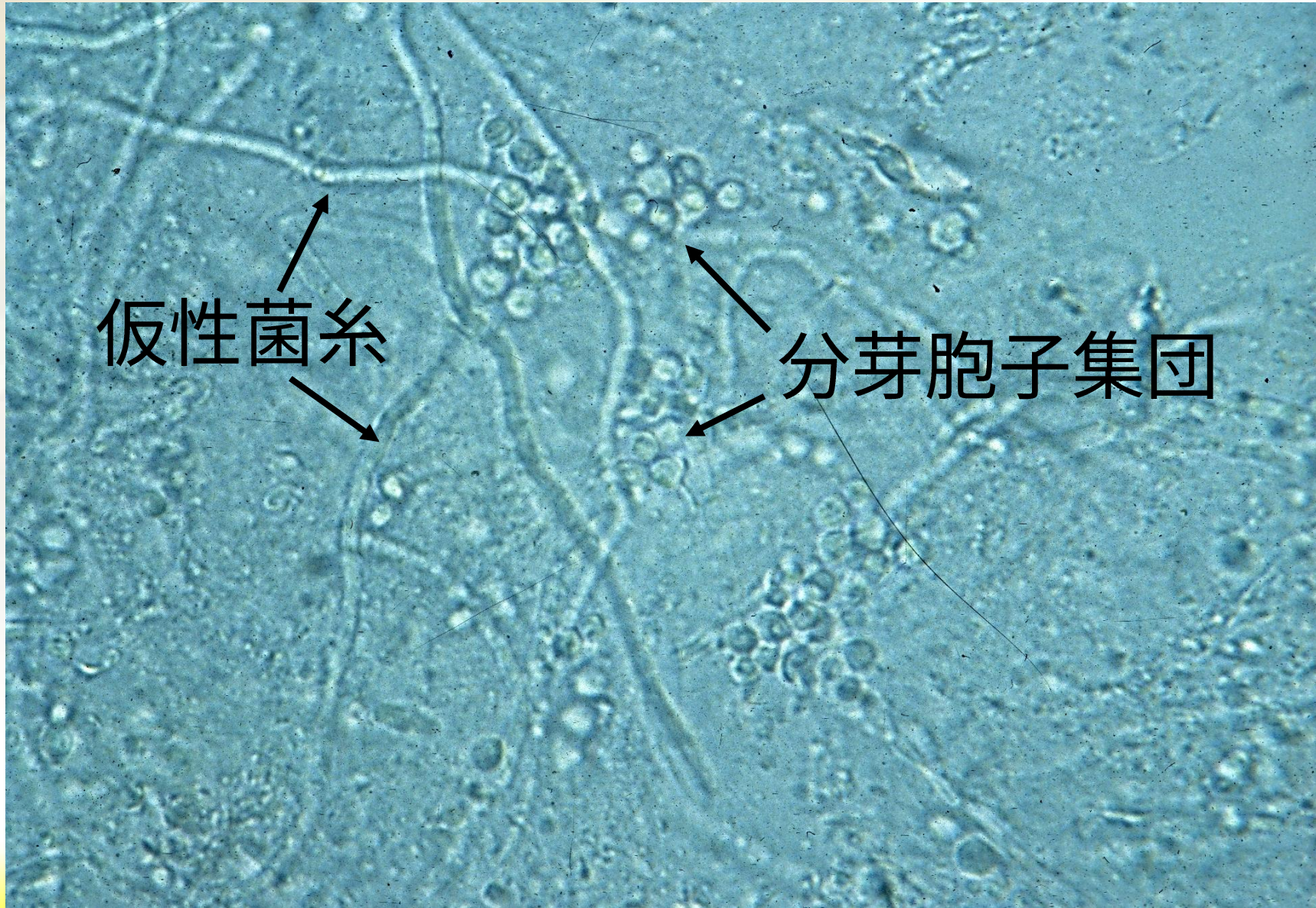
コンデンサー上下
ハンドル

コンデンサー
絞りレバー

真菌検査の際は
絞りは絞る！
コンデンサーは下げる！



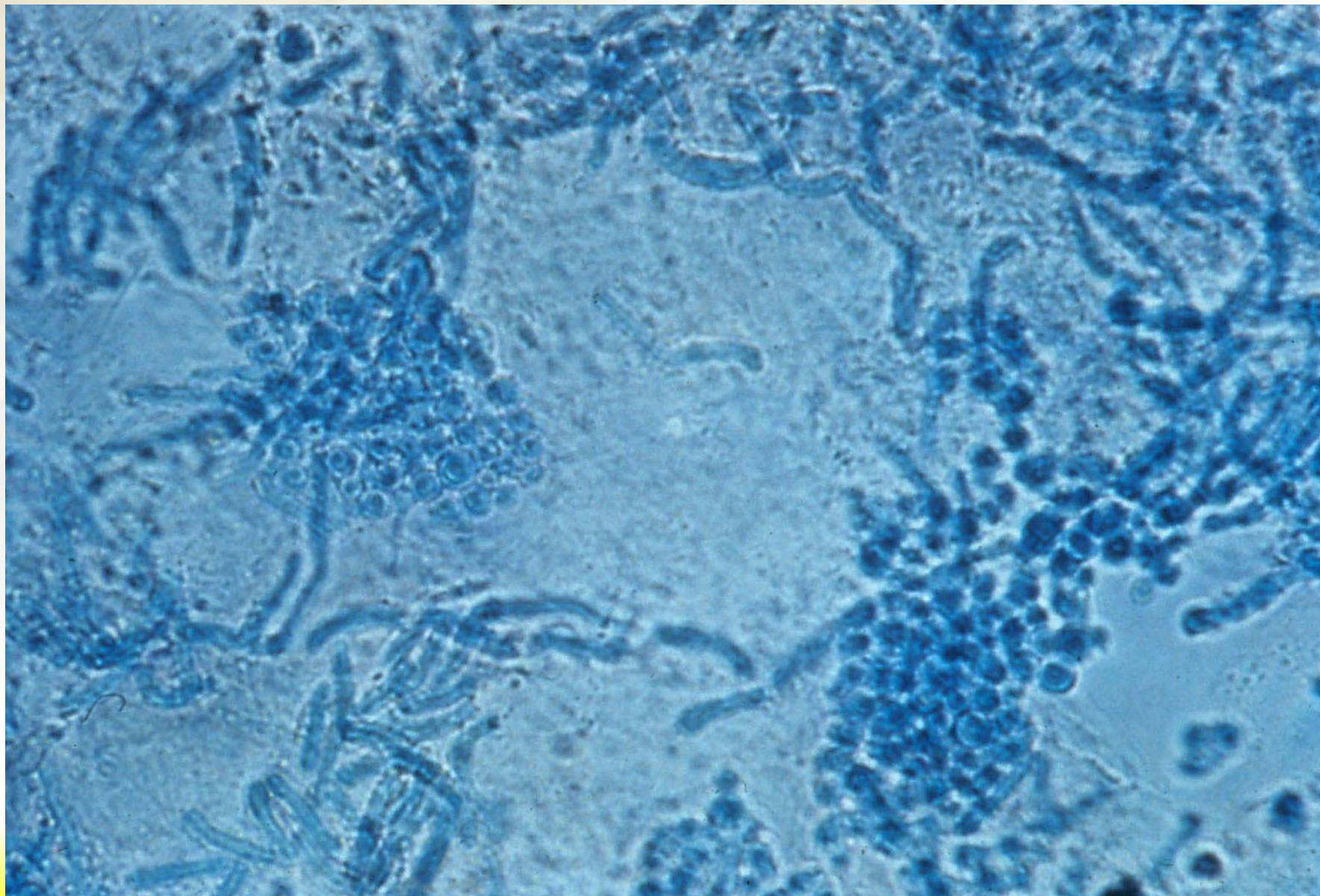
白癬菌



假性菌糸

分芽胞子集団

カンジダ



癩風菌

直接検鏡(KOH)

重要なのは、

- ① 真菌の存在する部位からしっかり検体を採取すること。
- ② 真菌が存在するかどうかを顕微鏡でしっかり判定すること。



デルマクイック爪白癬



①テストストリップ ②抽出液 ③テストチューブ ④攪拌棒

デルマクイック®爪白癬

テストチューブ



包装箱 5テスト用



抽出液

攪拌棒



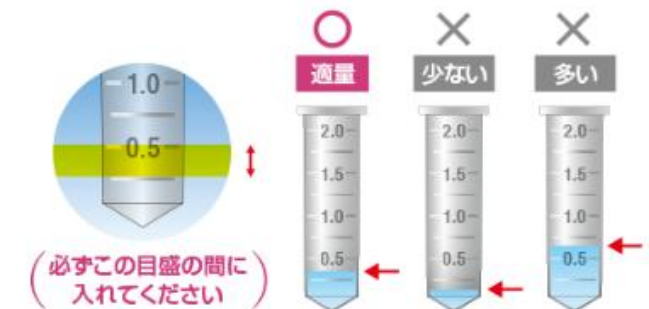
テストストリップ



検査方法

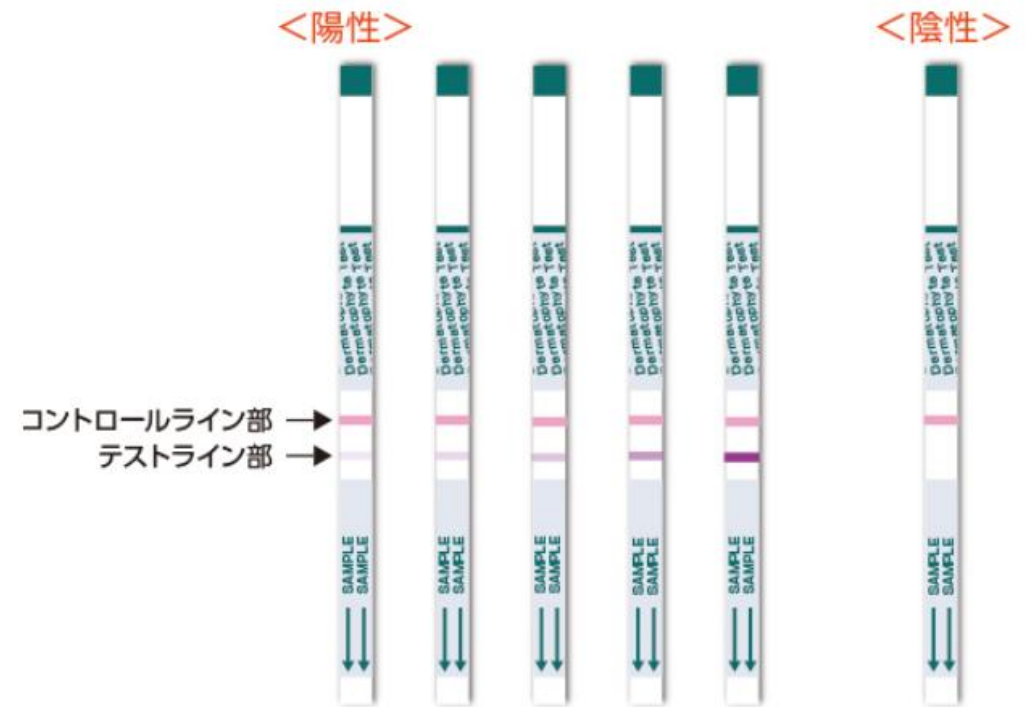
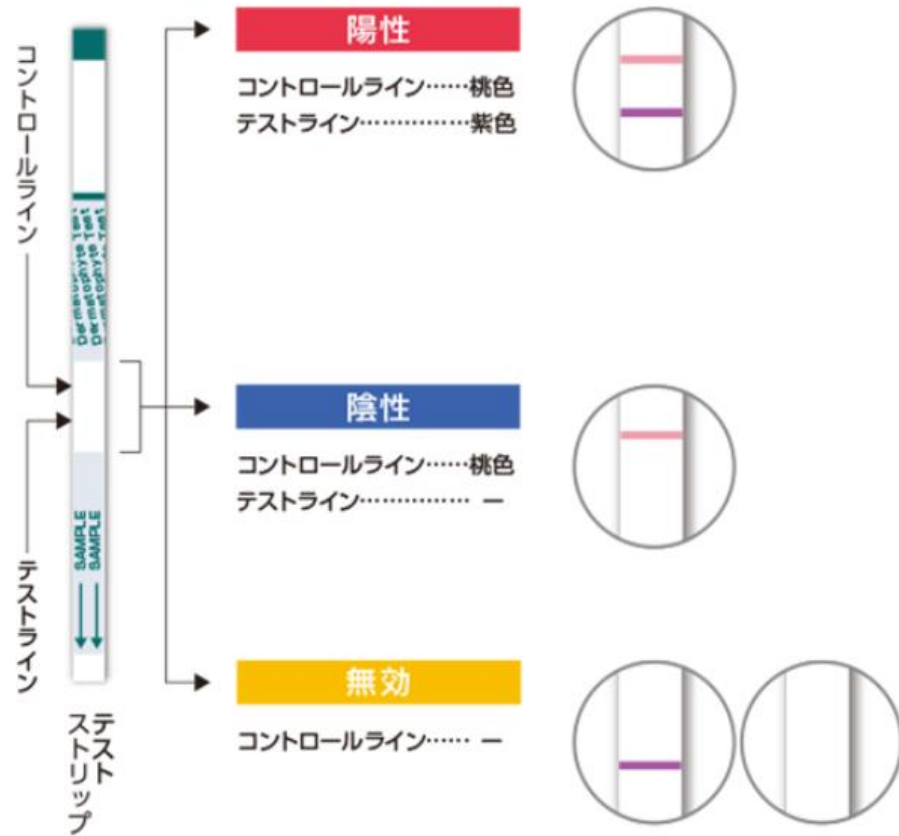


[抽出液の量]



※本キットは使用時に抽出液の分注作業が必要になります。

判定方法



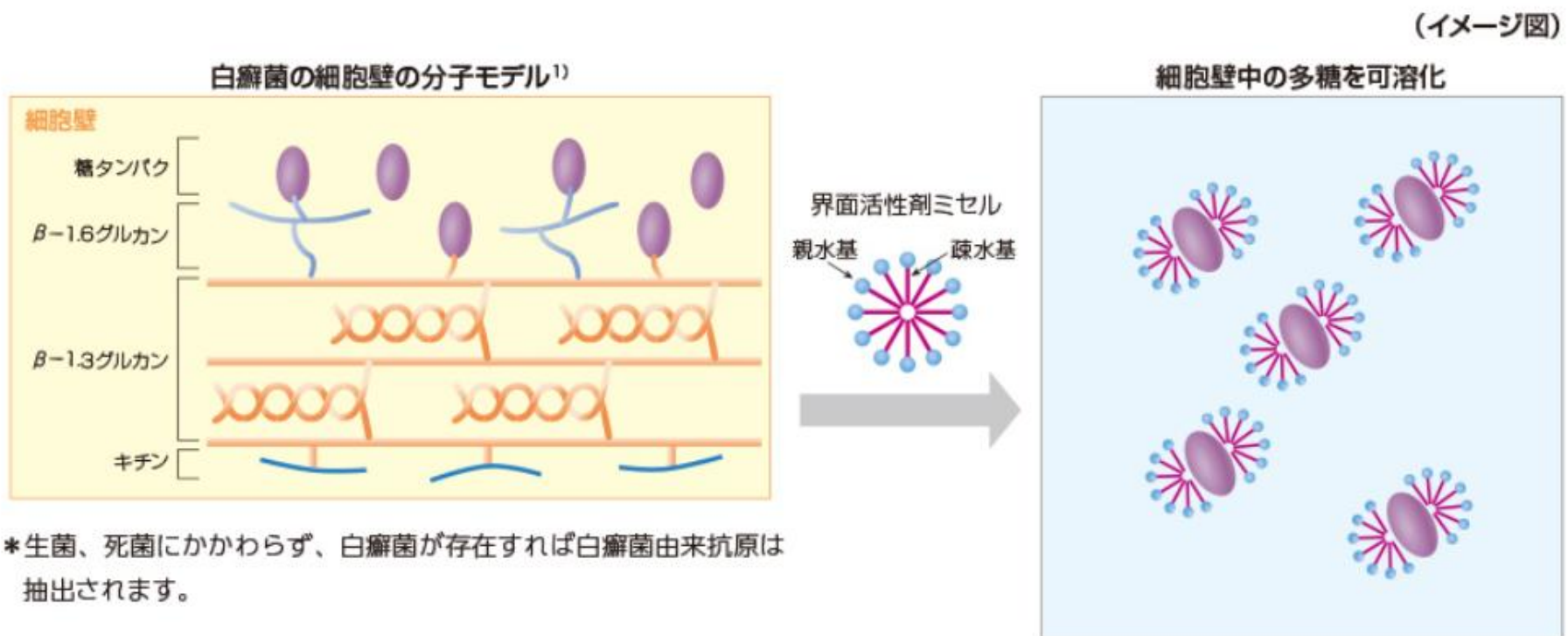
*5分以上30分以内にコントロールライン部に桃色のラインが出現しない場合は検査無効となります。

*5分以上30分以内にコントロールラインが出現し、30分を超過してからテストライン部にラインが出現した場合は陰性と判定します。

原理

白癬菌由来抗原の抽出原理

白癬菌の細胞壁に存在する多糖を界面活性剤のミセルで包み込み、水相に可溶化して、抽出します。これが、白癬菌由来抗原となります。



Reprinted from Curr Opin Microbiol., 2 (4), G J Smits et al, Cell wall dynamics in yeast, 348-52., Copyright (1999), with permission from Elsevier

検体採取方法

- ① 皮膚真菌症診断・治療ガイドラインに従って検体を採取し、キット付属のテストチューブに加えます。
採取器具は清浄なニッパー型爪切り、剪刀（外科用ハサミ）等を用いてください。
- ② 検体の採取は皮膚真菌症診断・治療ガイドラインに従い、教育訓練を十分に受けて習熟した医師により行ってください
- ③ 検体はおよそ1mg以上の量を採取してください。

● 遠位側縁爪甲下爪真菌症（DLSO）



爪の基部に近いところで、
深部を検査材料とする。

白癬菌は、足白癬病巣などから侵入し、
爪甲の伸びに逆行して移動する。

爪甲剥離部位や爪の先端部を除去し、できるだけ爪の基部に近いところで、深部（爪床に近い部位）を検査材料とする。爪の奥深くを採取できない場合は、爪甲剥離の下に存在する皮膚の表面（実際は爪床）を採取して検査材料とする。

● 表在性白色爪真菌症（SWO）



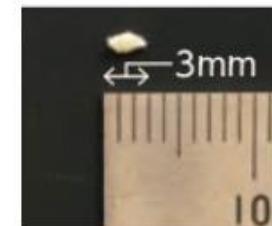
白濁した爪甲を薄く削り取って
検査材料とする。

爪甲表面の傷口から白癬菌が侵入する。

<参考>

爪検体1mgは、およそ爪 1mm^3 に相当します。

約1.5mgの爪検体の大きさ

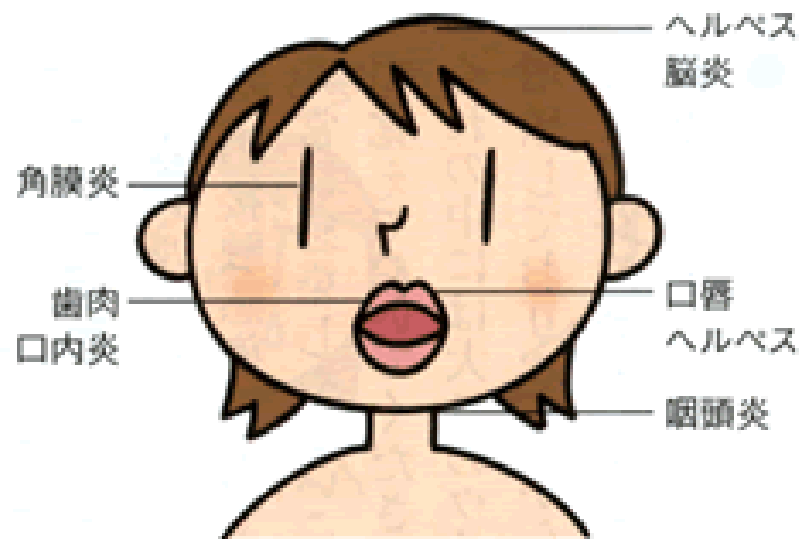


白濁した爪の表面をニッパー型爪切りや剪刀（外科用ハサミ）で削り取って、それを検査材料とする。

単純ヘルペスウイルス（HSV）は、生物学的、物理化学的、免疫学的差異からHSV-1とHSV-2の2型に分類されます。

単純ヘルペスウイルス1型

上半身に感染

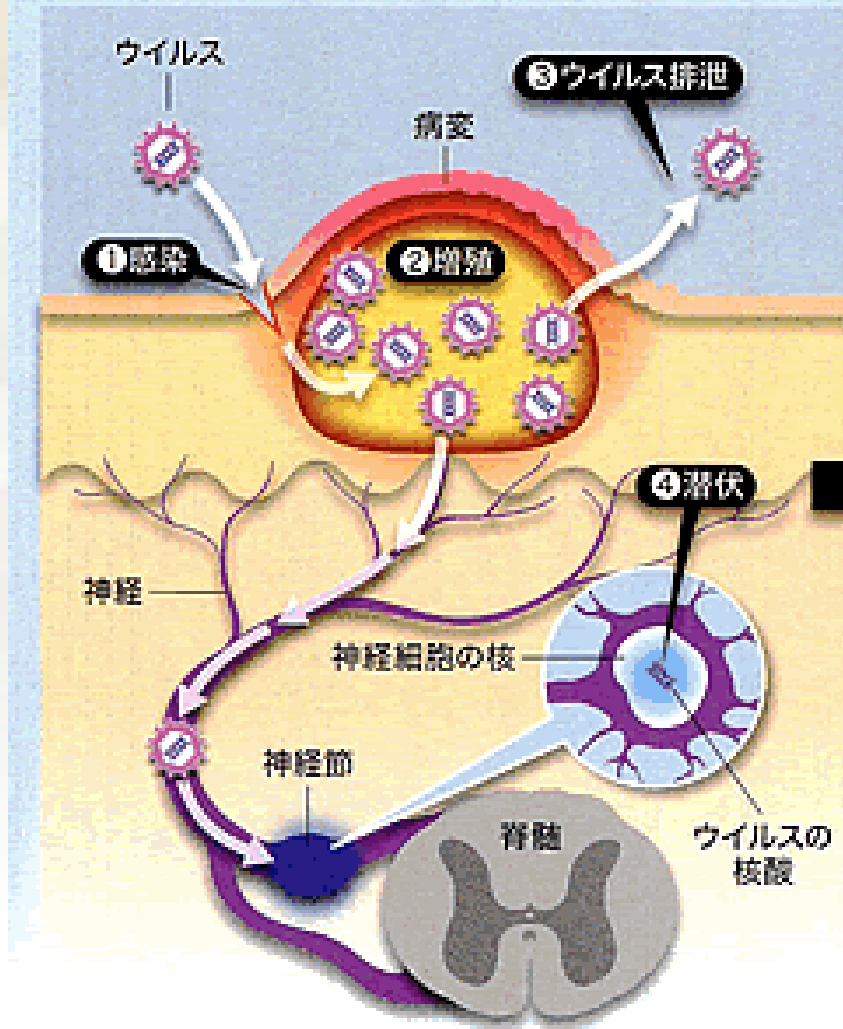


単純ヘルペスウイルス2型

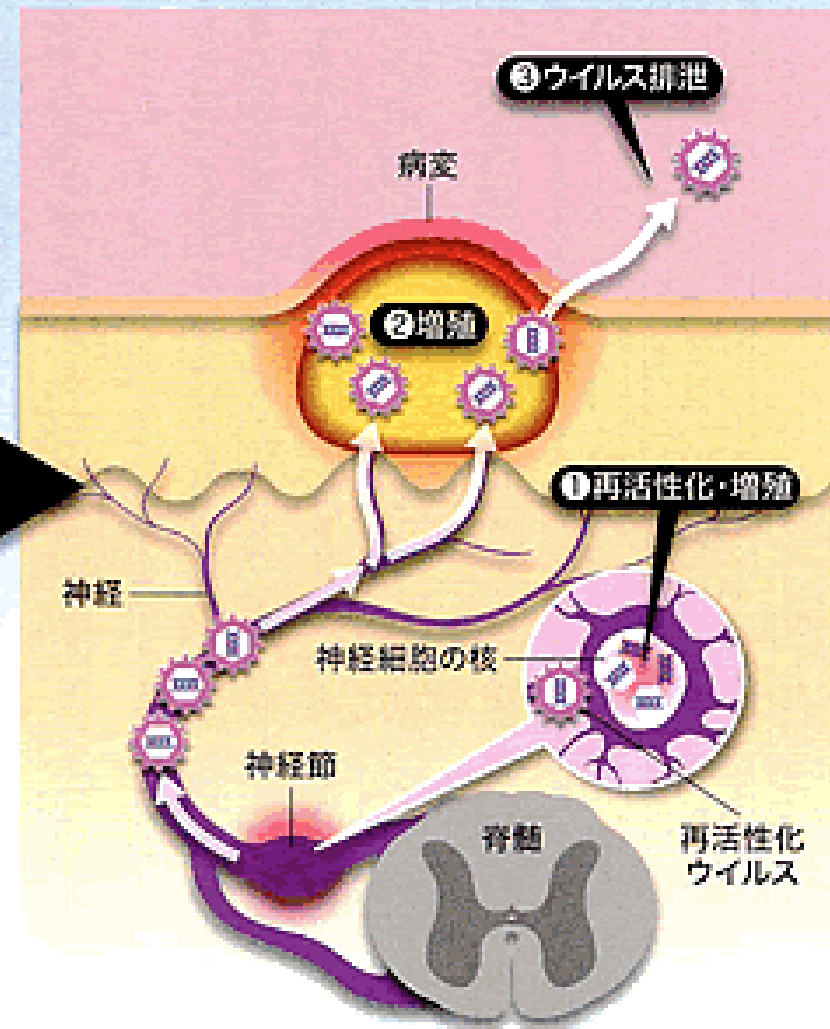
下半身に感染



● 初感染 ●



● 再 発 ●



初感染後、知覚神経節の神経細胞の核内に遺伝子の形態で潜伏し、HSV-1は顔面、特に口唇に再発し、HSV-2は下半身、特に性器に再発を繰り返す。

118F58

40歳の男性。右胸部から右背部の皮疹を主訴に来院した。7日前から右胸部の痛みを自覚した。5日前に右胸部から右背部にかけて皮疹が出現した。痛みが増強したため来院した。最近、過労気味であった。

胸部の写真(A 胸部, B：胸部の拡大)を別に示す。

写真Bでみられる皮疹の種類はどれか。2つ選べ。

1. 血疱
2. 紫斑
3. 水疱
4. 膿疱
5. 膿瘍



119A61

16歳の男子。発熱と皮疹を主訴に来院した。幼少期からアトピー性皮膚炎で治療を受けていたが、3か月前から治療を中断していた。2日前から39.9℃の発熱があり、顔面に皮疹が出現し体幹にも拡大したため受診した。疼痛はない。顔面と体幹に小水疱、びらん及び紅斑を両側性に認めた。顔面の写真(別冊No. 26)を別に示す。

原因で最も考えられるのはどれか

1. サイトメガロウイルス
2. 単純ヘルペスウイルス
3. 水痘・带状疱疹ウイルス
4. ヒトヘルペスウイルス6
5. Epstein-Barr(EB)ウイルス



Tzanck試験

ウィルス感染した表皮角化細胞を、Giemsa染色によって変性した細胞（Tzanck cell）として証明する方法

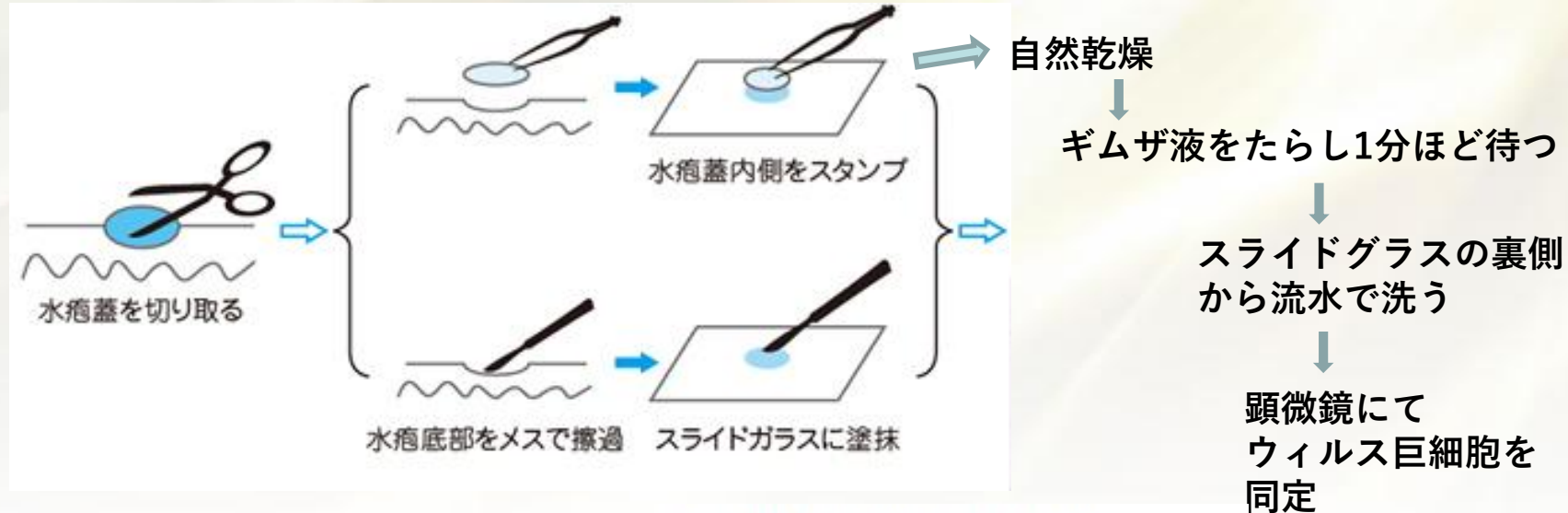
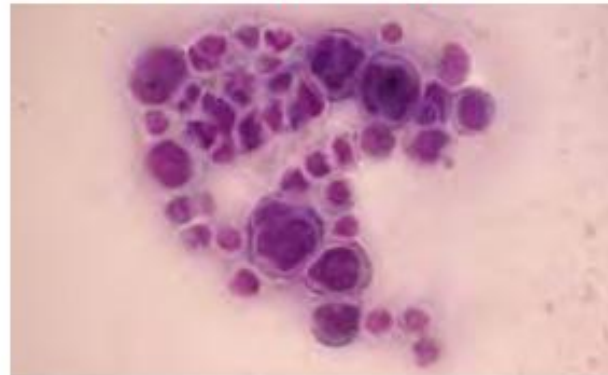
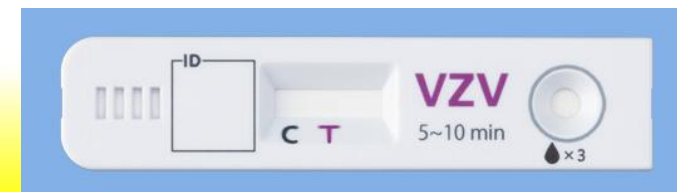
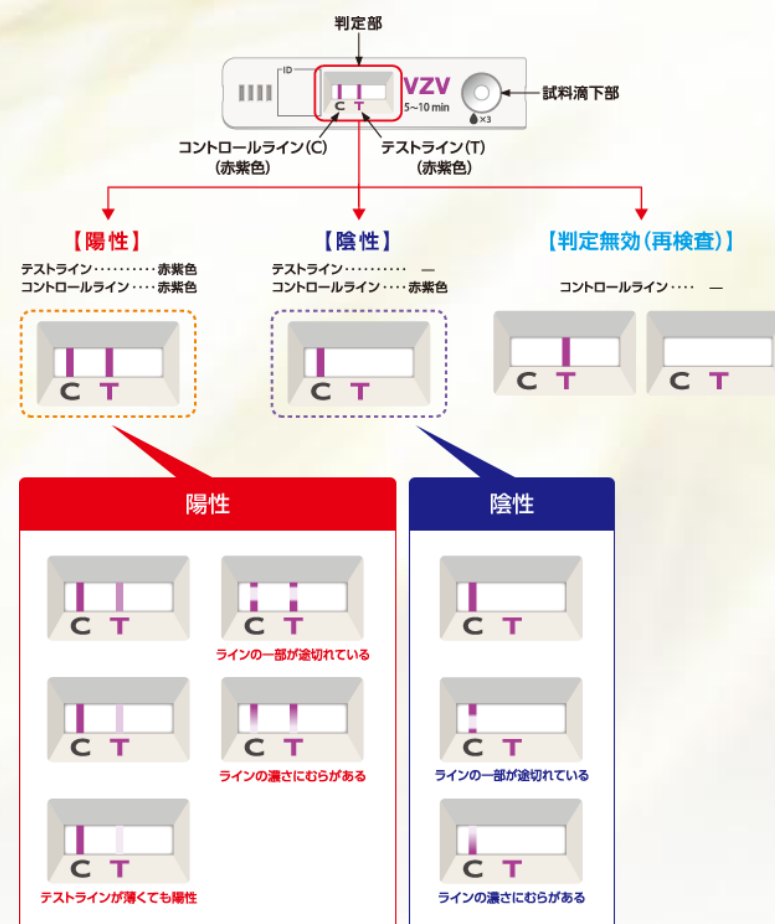
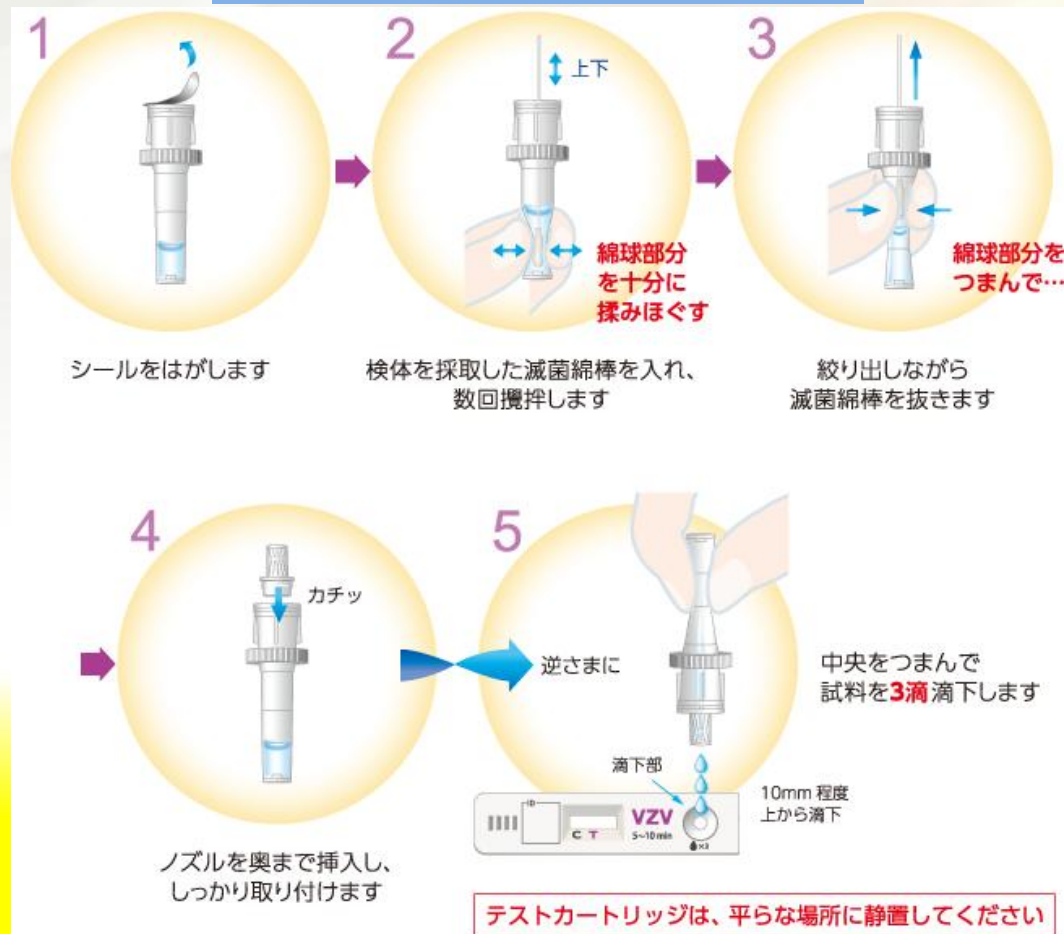


図1. ギムザ染色 ウィルス性巨細胞

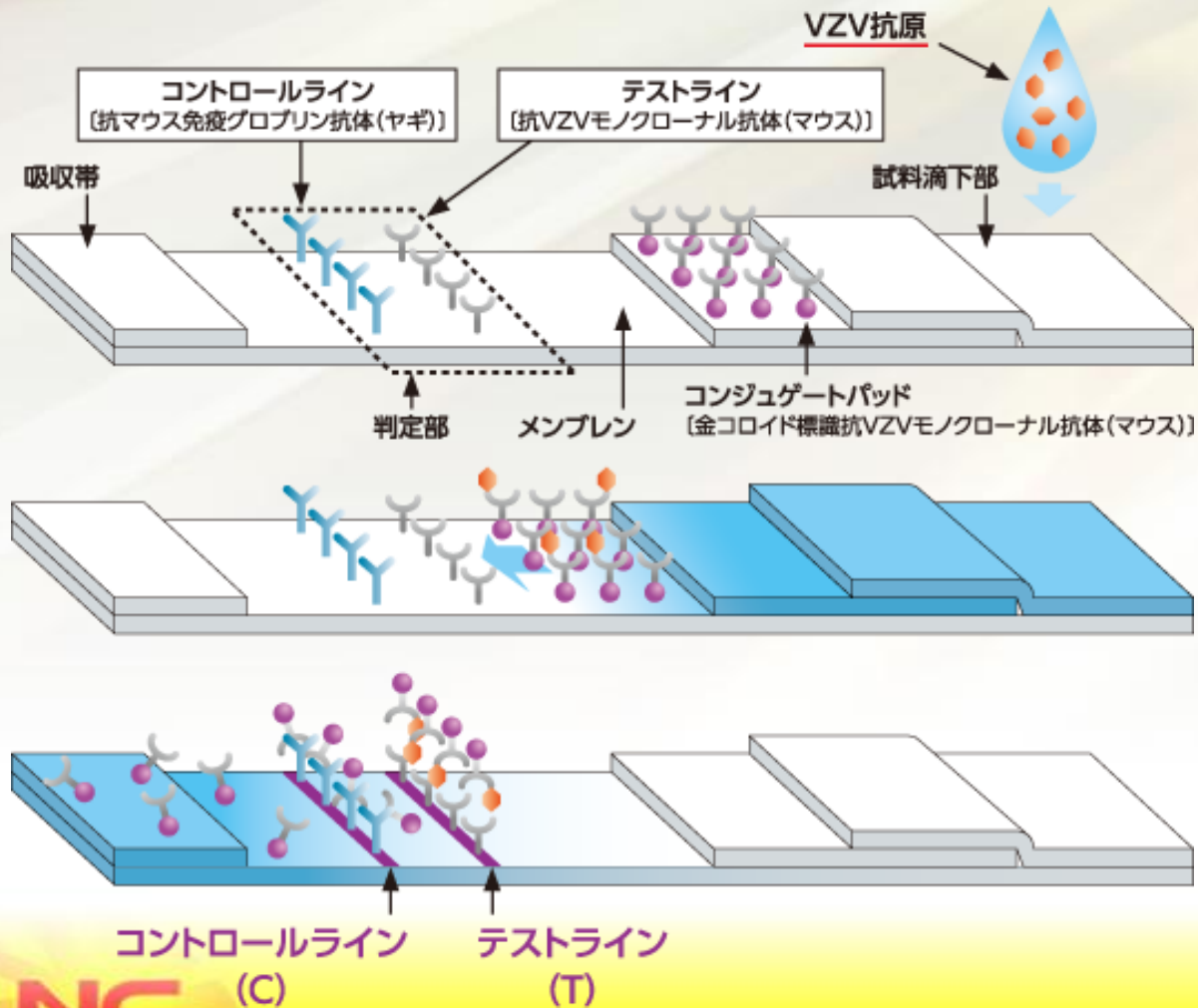


写真提供：本田 まりこ

デルマクイック®VZV



デルマクイック®VZV測定原理



①テストカートリッジの試料滴下部に滴下された試料中のVZV抗原は、コンジュゲートパッド中の金コロイド標識抗VZVモノクローナル抗体（マウス）と反応して免疫複合体を形成します。

②免疫複合体は、毛細管現象によりメンブレン上を移動し、判定部において、テストライン部に固相化された抗VZVモノクローナル抗体（マウス）に特異的に捕捉され赤紫色を呈することによって試料中のVZV抗原を検出します。

*試料中にVZV抗原が存在しなかった場合は免疫複合体が形成されず、金コロイド標識抗VZVモノクローナル抗体（マウス）を含む試料がテストライン部で捕捉されないため、テストラインは現れません。

③陽性、陰性にかかわらず、滴下された試料と反応しなかった金コロイド標識抗VZVモノクローナル抗体（マウス）は、コントロールライン部に固相化された抗マウス免疫グロブリン抗体(ヤギ)に捕捉されて赤紫色を呈します。これにより、展開が正常に進んだことを確認します。

重症下肢虚血の臨床像

動脈の高度な狭窄・閉塞により、安静時の痛みや潰瘍・壊死を呈する病態です。



主な症状

- ・安静時疼痛（夜間痛）
- ・下肢の冷感
- ・しびれ・知覚低下
- ・潰瘍・壊死

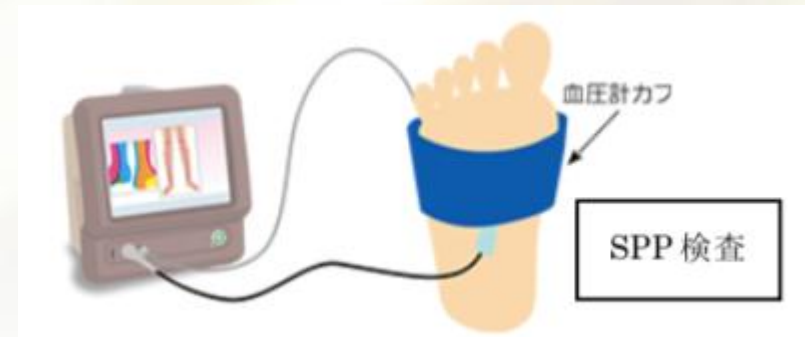
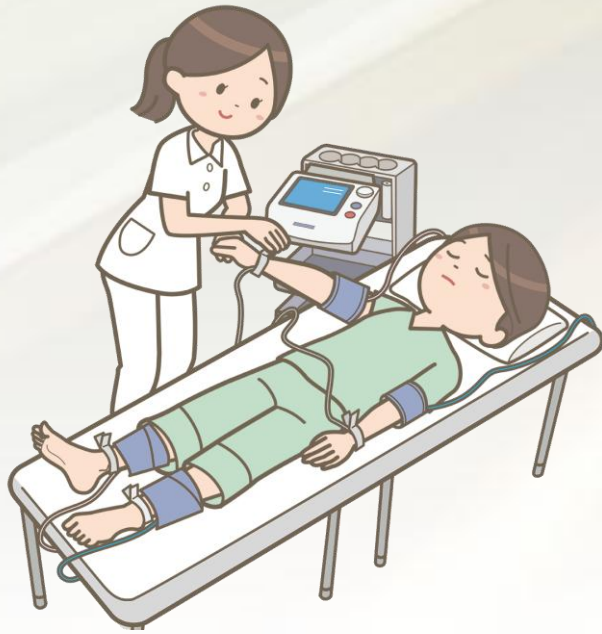
身体所見

- ・皮膚の蒼白、チアノーゼ
- ・皮膚温の低下（冷たい）
- ・潰瘍や壊死
- ・末梢動脈（足背動脈・後脛骨動脈）の拍動減弱または消失

ポイント

重症下肢虚血は、放置すると潰瘍の悪化や壊死の進行により
下肢切断に至るリスクが高い病態です。早期の診断と治療が重要です。

血流評価



ABI (Ankle Brachial index)

SPP (Skin Perfusion pressure)

アレルギーとは？

免疫反応が特定の抗原に対して過剰に起こること



アレルギー反応の分類

免疫反応による組織障害の機序から分類

		皮膚反応	主役	代表疾患
I 型反応	即時型 アナフィラキシー型	15～20分	IgE	アナフィラキシーショック、 アレルギー性鼻炎、 アレルギー性結膜炎、 気管支喘息、じんましん
II 型反応	細胞症障害型		IgG/IgM	溶血性貧血、ITP、 血小板減少症 Goodpasture症候群
III型反応	免疫複合体型 Arthus型	3～8時間	免疫複合体	SLE、RA、糸球体腎炎、 血清病
IV型反応	遅延型、 細胞性免疫	24～72時間	T細胞	接触皮膚炎、 アトピー性皮膚炎、 移植拒絶反応

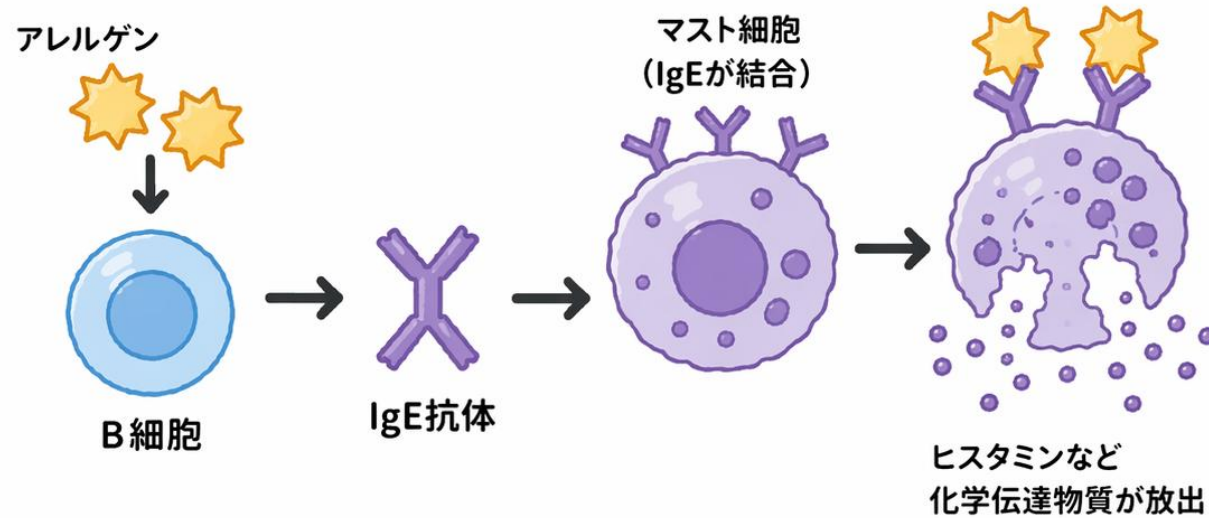


I 型反応

I 型反応(即時型アレルギー)

IgE抗体が関与し、マスト細胞からヒスタミンなどが放出され数分以内に起こるアレルギー反応。

- 1 アレルゲン
(花粉・食物など)
が体内に侵入
- 2 B細胞が
IgE抗体を産生
- 3 マスト細胞に
IgE抗体が結合
- 4 再度アレルゲンが
侵入し、IgEと結合
ヒスタミンなどが放出



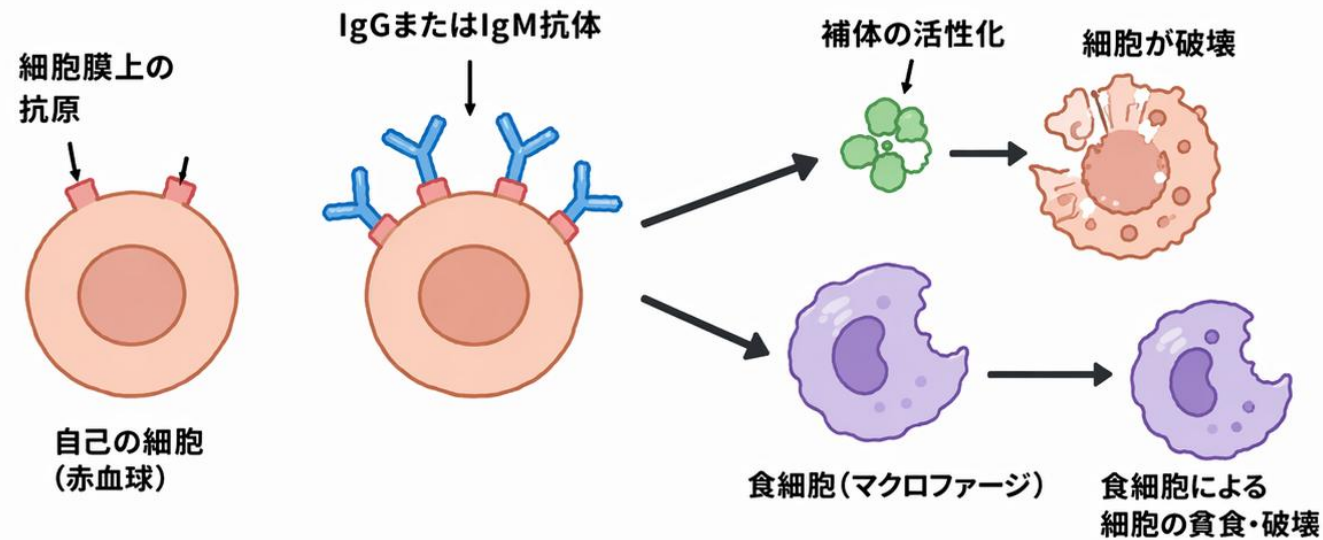
代表例 花粉症、蕁麻疹、アナフィラキシー

II型反応

II型反応（細胞障害型）

IgGやIgM抗体が自己の細胞膜抗原に結合し、補体の活性化や細胞傷害を引き起こす反応。

- 1 自己の細胞（赤血球など）に抗原が存在
- 2 IgGまたはIgM抗体が抗原に結合
- 3 補体が活性化されるまたは食細胞が作用
- 4 細胞障害が起こる



代表例

自己免疫性溶血性貧血、血小板減少性紫斑病

III型反応

Ⅲ型反応（免疫複合体型）

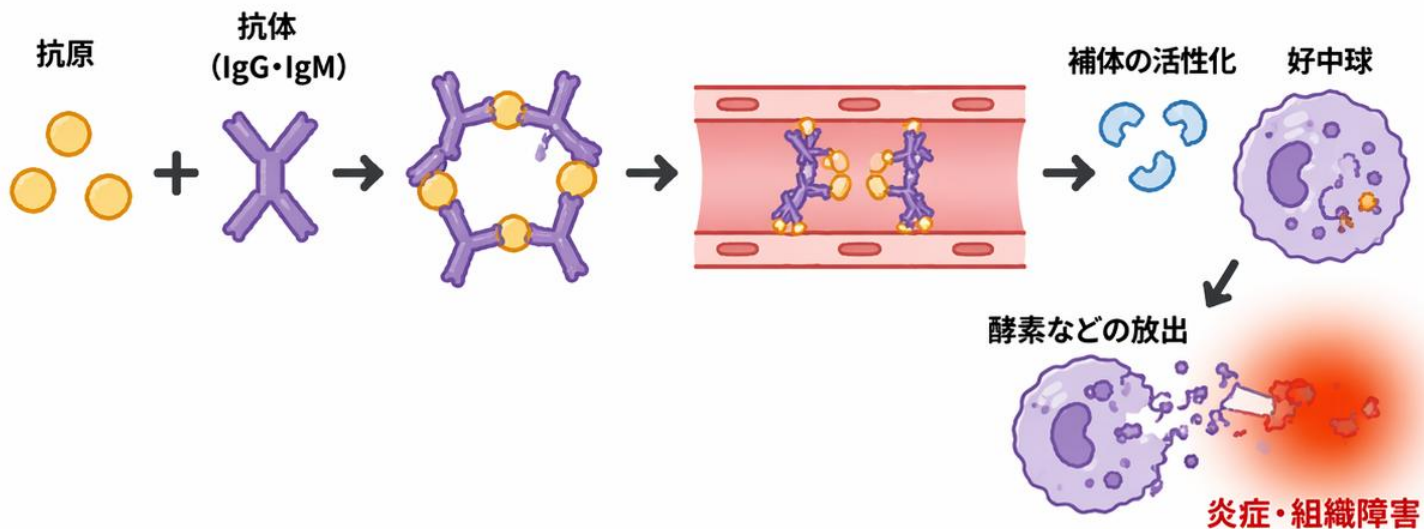
抗原抗体複合体（免疫複合体）が組織や血管に沈着し、補体活性化や好中球の浸潤により炎症が起こる反応。

① 抗原と抗体が結合する

② 免疫複合体（抗原抗体複合体）が形成される

③ 免疫複合体が血管壁などに沈着

④ 補体が活性化され好中球が集まり炎症・組織障害が起こる



代表例

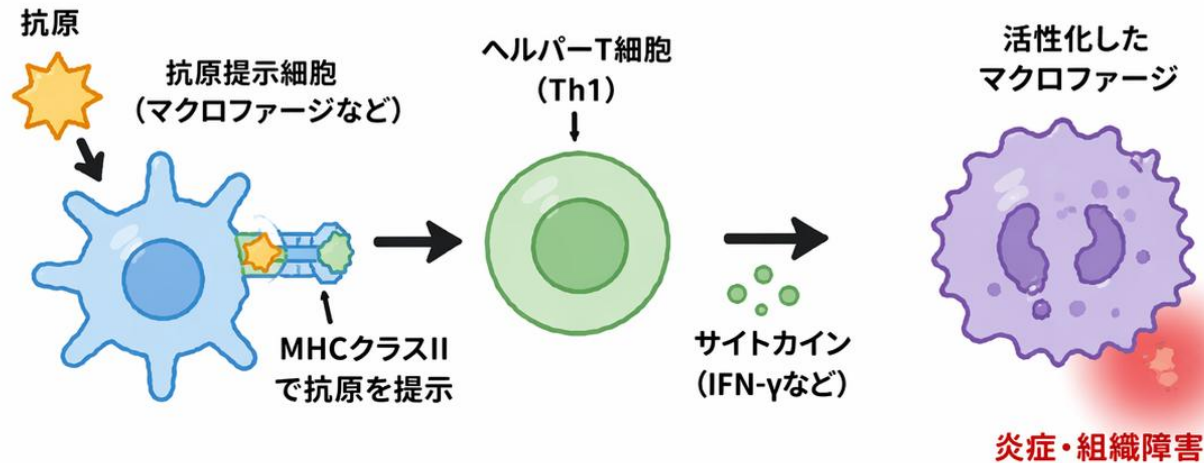
全身性エリテマトーデス（SLE）、
血清病、糸球体腎炎

IV型反応

IV型反応(遅延型アレルギー)

T細胞が主役となり、抗原刺激後24～72時間後に起こる遅いタイプの免疫反応。

- 1 抗原が体内に侵入
抗原提示細胞が
抗原を取り込み
T細胞に提示
- 2 ヘルパーT細胞
(Th1)が活性化
- 3 サイトカイン
(IFN- γ など)を
分泌してマクロ
ファージを活性化
- 4 活性化したマクロ
ファージなどが
炎症を起こし
組織障害を引き起こす



代表例

ツベルクリン反応(結核の検査)、
接触皮膚炎(かぶれ)



【症例1】 40才、女性

主訴：両眼瞼の腫脹

既往歴：特記すべきことなし

家族歴：特記すべきことなし

内服歴：なし



Q 何を問診するか？



経過

石けんの使用により、顔のかゆみが出るようになった。
症状は経年的に増悪する傾向にあった。
約2年後、食物依存性運動誘発アナフィラキシーを発症した。

（パンを食べた後にテニスをしたところ、15分後に、
目のかゆみが始まり、続いて顔面の発赤・腫脹、
全身の発赤・膨疹、その後の血圧低下、腹痛等、
アナフィラキシー反応が起きた。）





小麦の加水分解物の中でも「グルパール19S」

加水分解コムギ末を含有する石けん使用後の顔のかゆみの他、小麦含有食品摂取後の運動時にアナフィラキシー反応等の全身性のアレルギー（食物依存性運動誘発アナフィラキシー）を発症した症例が複数報告された。

アレルギー疾患の検査

I 型アレルギー反応

in vivo: プリックテスト

in vitro: 抗IgE抗体測定、MAST
(Multiple allergen simultaneous test)

IV型アレルギー反応（細胞性免疫）

in vivo: パッチテスト

in vitro: リンパ球刺激試験(DLST)



★皮膚テスト

抗原負荷

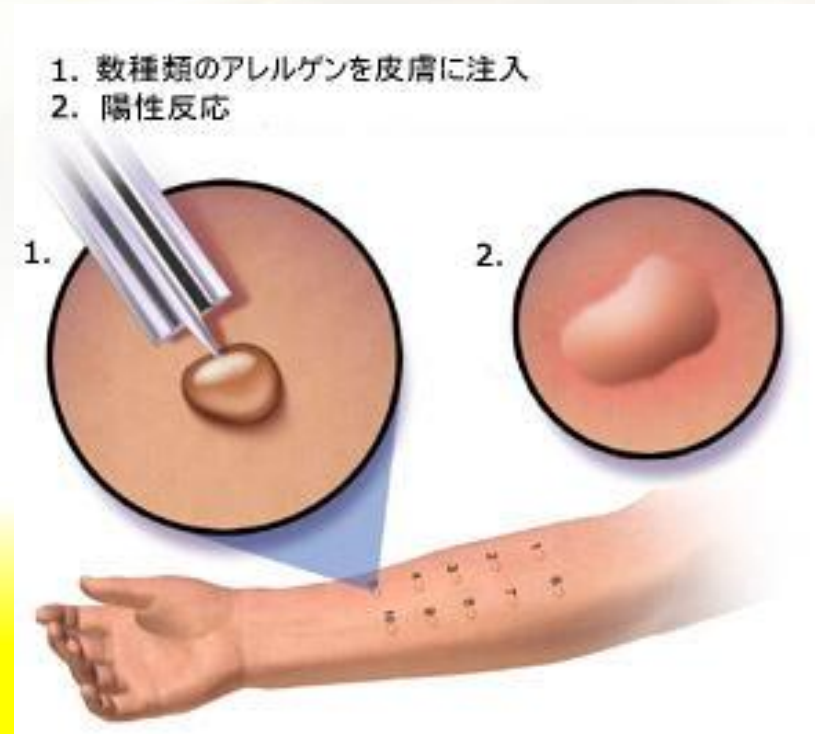
プリックテスト<スクラッチテスト<皮内テスト

⇒アナフィラキシーを誘発する
危険性が高まる



プリックテスト

- 準備：①ランセット針
②抗原（アレルゲン）
③対照液：陰性コントロール
陽性コントロール
(1%二塩酸ヒスタミン水溶液)



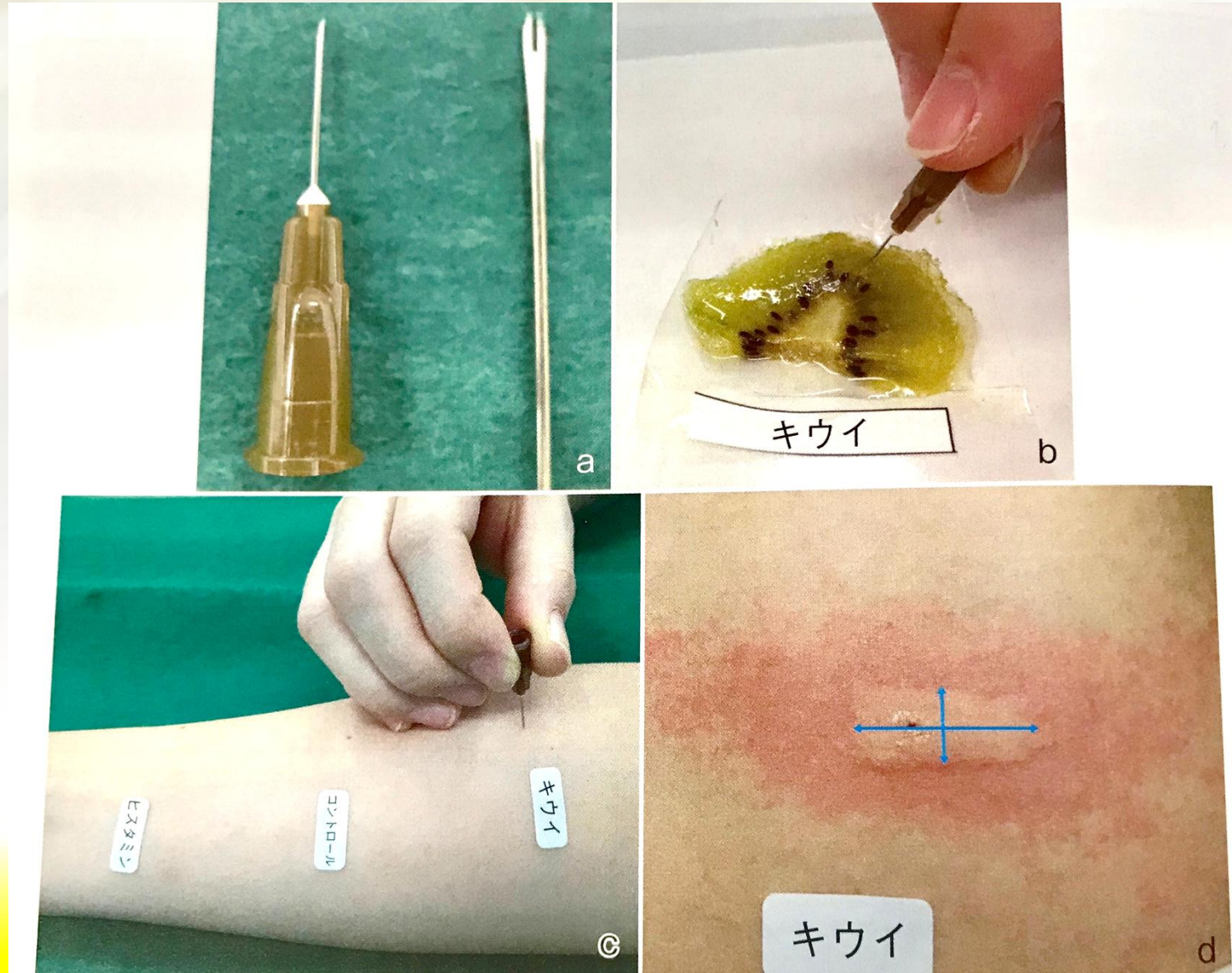
プリックテスト

- ・ 検査部位： 基本的には前腕伸側
各抗原は3cm程度離す。
- ・ 評価： 抗原液を皮膚に刺してから15分後
に膨疹の大きさ
(最長径＋その中点に垂直な径) /2を測定する

測定	スコア	判定
陰性対照	－	陰性
ヒスタミンの1/2より小さい	1＋	陰性
ヒスタミンの1/2以上	2＋	陽性
ヒスタミンと同等以上	3＋	陽性
ヒスタミンの2倍以上	4＋	陽性



プリック・プリックテスト



★ラテックスアレルギー

天然ゴム製品に接触することによって起こるじんま疹、アナフィラキシーショック、喘息発作などの即時型アレルギー反応。
初めて1979年のNutterによる接触蕁麻疹の患者さんの報告です。

ハイリスクグループ

①医療従事者

特に手指にアトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎がある場合

②繰り返し医療処置を受けている患者

欧米では二分脊椎症患者

③食物アレルギー患者

特にラテックス・アレルゲンと交叉抗原性を持つアボガド、バナナ、クリ、キウイフルーツ等アレルギーがある場合

④天然ゴム製造業従事者

➡ 感作に注意する



ラテックス-フルーツ症候群 (latex-fruit syndrome)

●表

ラテックスと交差抗原性を照明された主なフルーツラテックスアレルギー患者の約5割が、これらの食品に対して過敏反応（アナフィラキシー、喘鳴、蕁麻疹、OAS）を有することが報告されている。

花粉	果物・野菜
スギ	トマト
シラカンバ	リンゴ、モモ、サクランボ
イネ科	トマト、スイカ、メロン、オレンジ
ヨモギブタクサ	メロン、スイカ、セロリ

- * 1) 出典：Kondo Y. et al Clin. Exp. Allergy 2002; 32:590-594
2) 出典：鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版：表42（一部改変）
3) 出典：安達俊秀,ほか アレルギー・免疫 2011;8:886-892.

【症例2】

41才、女性

既往歴：アレルギー性鼻炎、じんましん

現病歴：数か月前から頭皮のかゆみとフケ、赤みを自覚。



Q.どうやって原因のアプローチするか？



現病歴：

数か月前から頭皮のかゆみとフケ、赤みを自覚。洗髪後に悪化するため、シャンプーが合わないと考えて種類を幾度か変えたが症状が徐々に増悪したため、使用を中止。洗髪には浴用石鹸を使用していた。

当科初診時にはシャンプーの使用中止によって症状が軽減していたことから、シャンプーによる接触皮膚炎が疑われた。



パッチテストに使用する検査道具





貼付部位



パネル1 1枚



パネル2 1枚



パッチテストをお受けになった患者さまへ 判定結果



かぶれの原因物質

あなたのかぶれの原因物質は以下のうち、チェックを付けたものです。
なるべく原因物質を避けるようにしてください。

No.	原因物質	種類	注意すべき生活用品
☐ 1	ニッケル	金属	アクセサリ（ピアスなど）、腕時計、ベルトのパックル、硬貨、携帯電話、ビューラー、歯科用金属など
☐ 2	ラノリン	油脂	つや出し、化粧品、クリーム、塗り薬など
☐ 3	フラジオマイシン	医薬品	塗り薬、目薬
☐ 4	クロム	金属	革製品（靴、ブーツ、グローブ）、なめし剤、セメント、クロムメッキ、歯科用金属、染料など
☐ 5	カインミックス （アミノ安息香酸エチル、ジブカイン塩酸塩、テトラカイン塩酸塩）	医薬品	塗り薬、局所麻酔剤 
☐ 6	香料ミックス （ α -アミルシナムアルデヒド、イソオイゲノール、ケイ皮アルデヒド、オイゲノール、ケイ皮アルコール、ヒドロキシシトロネラール、ゲラニオール、オークモス）	香料	食品、キャンドル、香水、化粧品、塗り薬、石鹸、トイレットペーパーなど 
☐ 7	ロジン（精製松脂）	樹脂	インク、ニス、塗料、ワックス、化粧品、接着剤、滑り止め（野球のロジンバッグ）など
☐ 8	パラベンミックス （メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベン、ベンジルパラベン）	防腐剤	食品、化粧品、塗り薬、シャンプー、リンス、石鹸など 
☐ 10	ペルーバルサム	樹脂	香料、化粧品、アロマオイル、ソフトドリンク、日焼け止めなど
☐ 11	金	金属	貴金属、アクセサリ、電子部品、歯科用金属など 
☐ 12	コバルト	金属	歯科用金属、セメント、インク、絵具、鍵、ファスナー、エナメル、ビタミンB ₁₂ 製剤など

メモ欄

No.	原因物質	種類	注意すべき生活用品
☐ 13	p-tert-ブチルフェノール ホルムアルデヒド樹脂	樹脂	ゴム・革製品（靴、ハンドバック、時計のベルト、帽子、ベルトなど）の接着剤など 
☐ 14	エポキシ樹脂	樹脂	電化製品の接着剤や塗料、コーティング剤など
☐ 15	カルバミックス	ゴム硬化剤	ゴム製品（ブーツ、靴、ゴーグル、イヤホン、医療用手袋など）
☐ 16	黒色ゴムミックス	ゴム老化防止剤	黒色のゴム製品（タイヤ、ベルト、マスク、ホース、手袋、ゴーグルなど）
☐ 17	イソチアゾリノンミックス （クロロメチルイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン）	防腐剤	外国製化粧品、シャンプー、リンス、ウェットティッシュ、工業用防腐剤など 
☐ 19	メルカプトベンゾチアゾール	ゴム硬化剤	ゴム製品（ブーツ、靴、ゴーグル、マット、ウェットスーツ、医療用手袋など）
☐ 20	パラフェニレンジアミン	染料	おしゃれ染め、白髪染め、織物・毛皮などの染料、インク、ヘナタトゥーなど
☐ 21	ホルムアルデヒド	防腐剤	衣類の仕上げ剤、接着剤、塗料など
☐ 22	メルカプトミックス	ゴム硬化剤	ゴム製品（ブーツ、靴、ゴーグル、マット、ヘッドフォン、コード、ホース、消しゴムなど）
☐ 23	チメロサル	防腐剤	ワクチンなどの注射用製剤
☐ 24	チウラムミックス	ゴム硬化剤	ゴム製品（ブーツ、靴、接着剤、プラグ、ゴーグル、マット、ヘッドフォン、ホースなど） 

判定

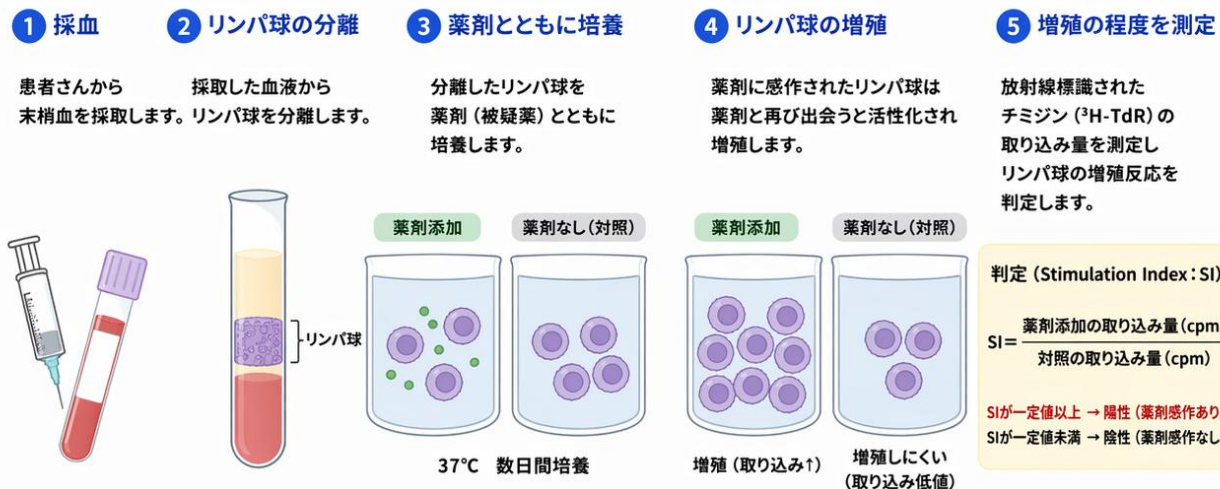
パッチテスト判定基準		
* International Contact Dermatitis Research Group(ICDRG)基準		
? (+)		疑陽性 紅斑のみ(腫れていない赤味のみ)
+(1+)		陽性 浮腫のある紅斑
++(2+)		紅斑+丘疹、小水泡
+++ (3+)		大水疱
(-)		反応なし
IR		明らかに毒性による反応(浅い壊死) * Irritation という意味でのアレルギー反応ではない

図11 パッチテストの判定基準

リンパ球幼若化試験 (drug-induced lymphocyte stimulation test ; DLST)

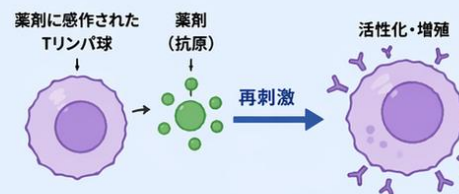
DLST (薬剤リンパ球刺激試験) の原理

薬剤に対する遅延型アレルギー (IV型反応) を、患者さんのリンパ球の増殖反応として in vitro (試験管内) で検出する検査です。



DLSTの意義

生体内で起こる遅延型アレルギー反応と同様に、薬剤特異的に活性化したTリンパ球の増殖を指標として、薬剤アレルギーの関与を調べることができます。



医師国家試験

117A67

76歳の男性。全身の強い掻痒を主訴に来院した。介護老人保健施設に入所中である。2ヶ月前から全身に掻痒があり、掻痒のために夜も眠れないことがある。腋窩、体幹、四肢、手掌および陰部に紅色の丘疹や掻爬痕がみられる。手掌の丘疹部から採取した検体の顕微鏡写真を別に示す。
正しいのはどれか。

- 1.蚊により媒介される
- 2.有効な治療薬はない
- 3.ヒトからヒトへ感染する
- 4.近年はまれな疾患となった
- 5.アトピー性皮膚炎の原因の一つである

No. 36

(A 問題67)



医師国家試験

120A70

4歳の女児。皮疹、両足関節の痛みおよび腹痛を主訴に来院した。1週間前に発熱と咽頭痛が出現し、自宅近くの診療所を受診した。2日前から発疹と両足関節の痛みが出現した。今朝から腹痛を訴えているため受診した。体温36.9℃。脈拍68/分、整。眼瞼結膜と眼球結膜に異常を認めない。咽頭に発赤を認めない。扁桃に腫大を認めない。頸部リンパ節を触知しない。腹部は平坦、軟で、臍周囲に圧痛を認める。尿所見：蛋白（－）、糖（－）、潜血（－）。血小板値正常。凝固系異常なし。

この患児で注意すべき合併症はどれか。2つ選べ。

- 1.腎炎
- 2.冠動脈瘤
- 3.腸重積症
- 4.間質性肺炎
- 5.大動脈閉鎖不全症

No. 32

(A 問題 70)

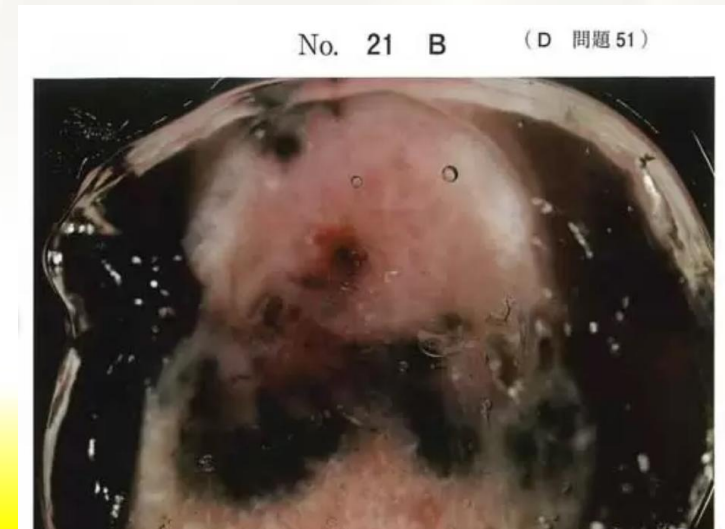


医師国家試験

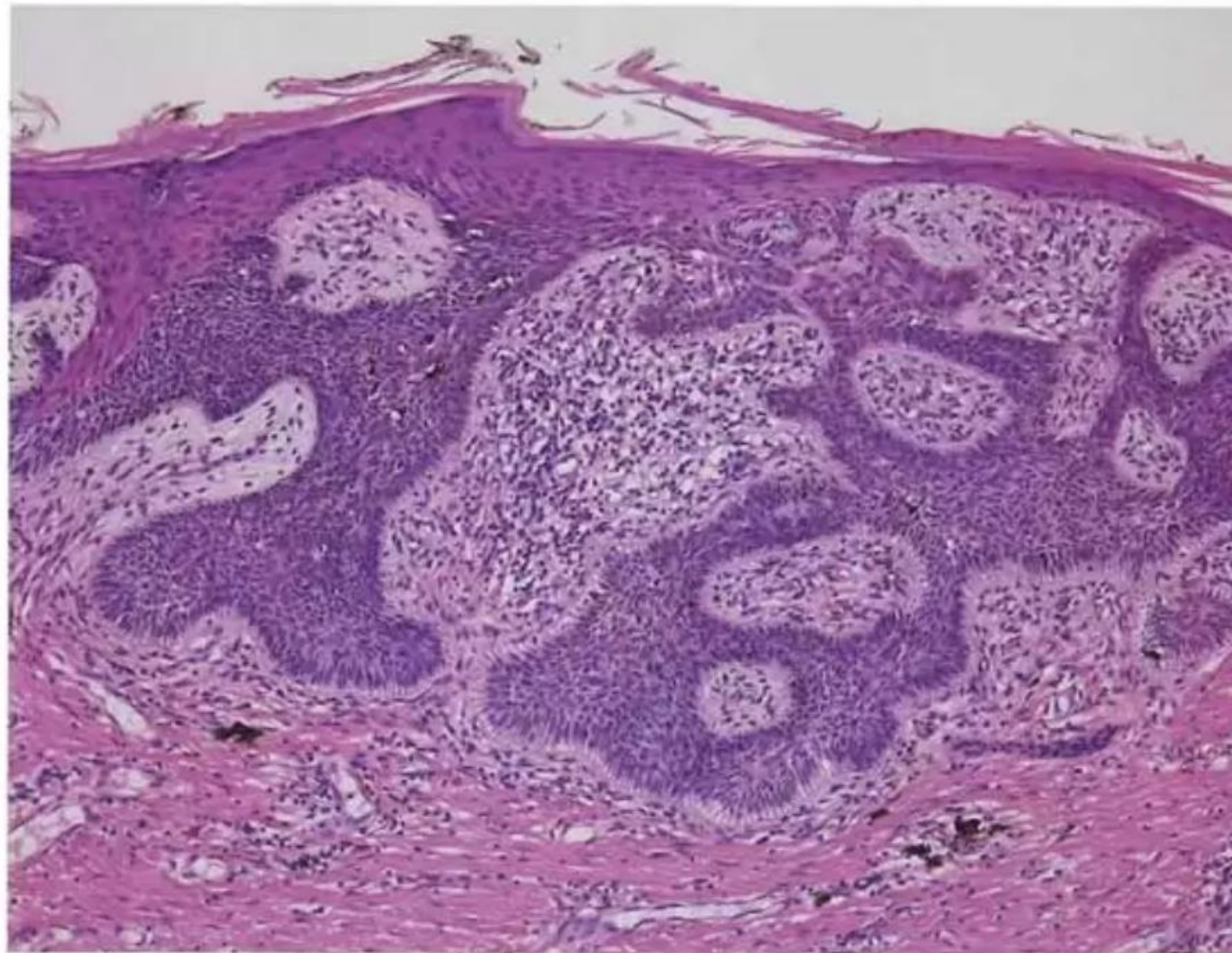
120D51

75歳の男性。鼻部の皮疹を主訴に来院した。約2年前から鼻根部に小さな皮疹が出現したが、医療機関を受診しなかった。徐々に増大し、中心部が少し凹み、縁が堤防状に盛り上がってきた。時々、かさぶたが付着し、剥がれるとわずかに出血することがあったが、痛みやかゆみはない。鼻根部に長径20mmの結節を認める。頸部リンパ節の腫大はない。鼻部の皮疹の写真（別冊No.21A）とダーモスコピー像（別冊No.21B）を別に示す。診断はどれか？

1. 悪性黒色腫
2. 基底細胞癌
3. 日光角化症
4. 有棘細胞癌
5. 脂漏性角化症



基底細胞癌(Basal cell carcinoma)



★病理組織学的ポイント ①柵状配列(Palisading) ②裂隙形成(cleft)

医師国家試験

120D66

24歳の女性。リンゴを食べた直後に口腔内の違和感と咽頭掻痒感を訴えて受診した。症状は数分以内に消失し、全身症状は認めなかった。診断に最も有用な検査はどれか。

1. 口腔粘膜生検
2. パッチテスト
3. プリックテスト
4. 血清総IgE抗体測定
5. 末梢血好酸球数測定

